MERCADO E OPERADORAS DE SAÚDE

PROF. REGINA MELLO

O QUE VAMOS ESTUDAR

01
MERCADO DE SAÚDE

02
PRODUTO
Planos privados de assistência à saúde ou odontológicos

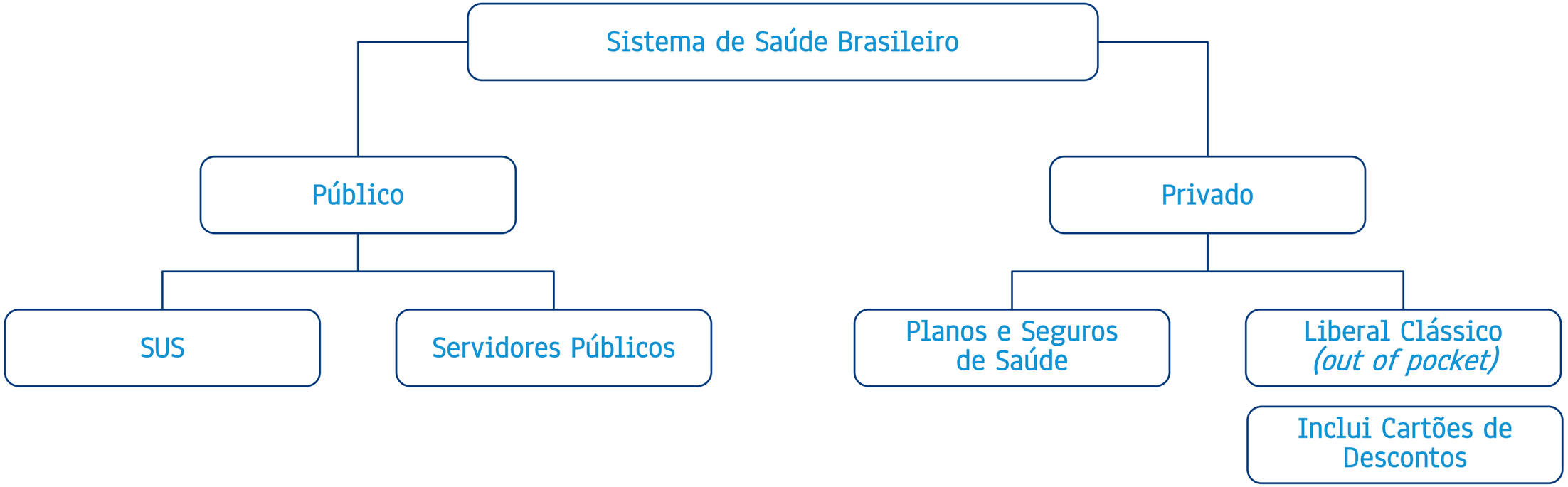
03
OPERADORAS DE SAÚDE

04
REGULAÇÃO ANS

05
INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES

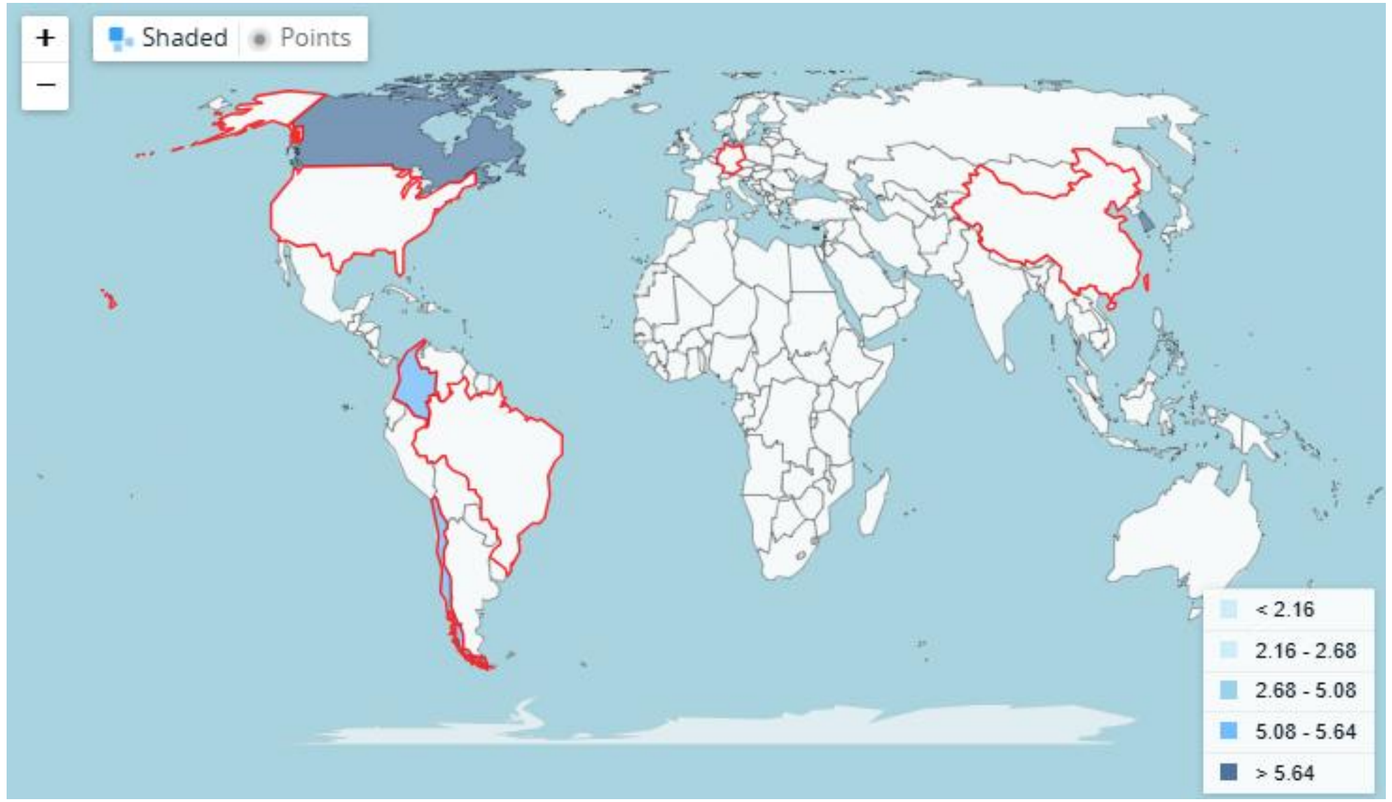
MERCADO DE SAÚDE

Representação esquemática do sistema de saúde brasileiro



MERCADO DE SAÚDE

Gastos com saúde / PIB (%)



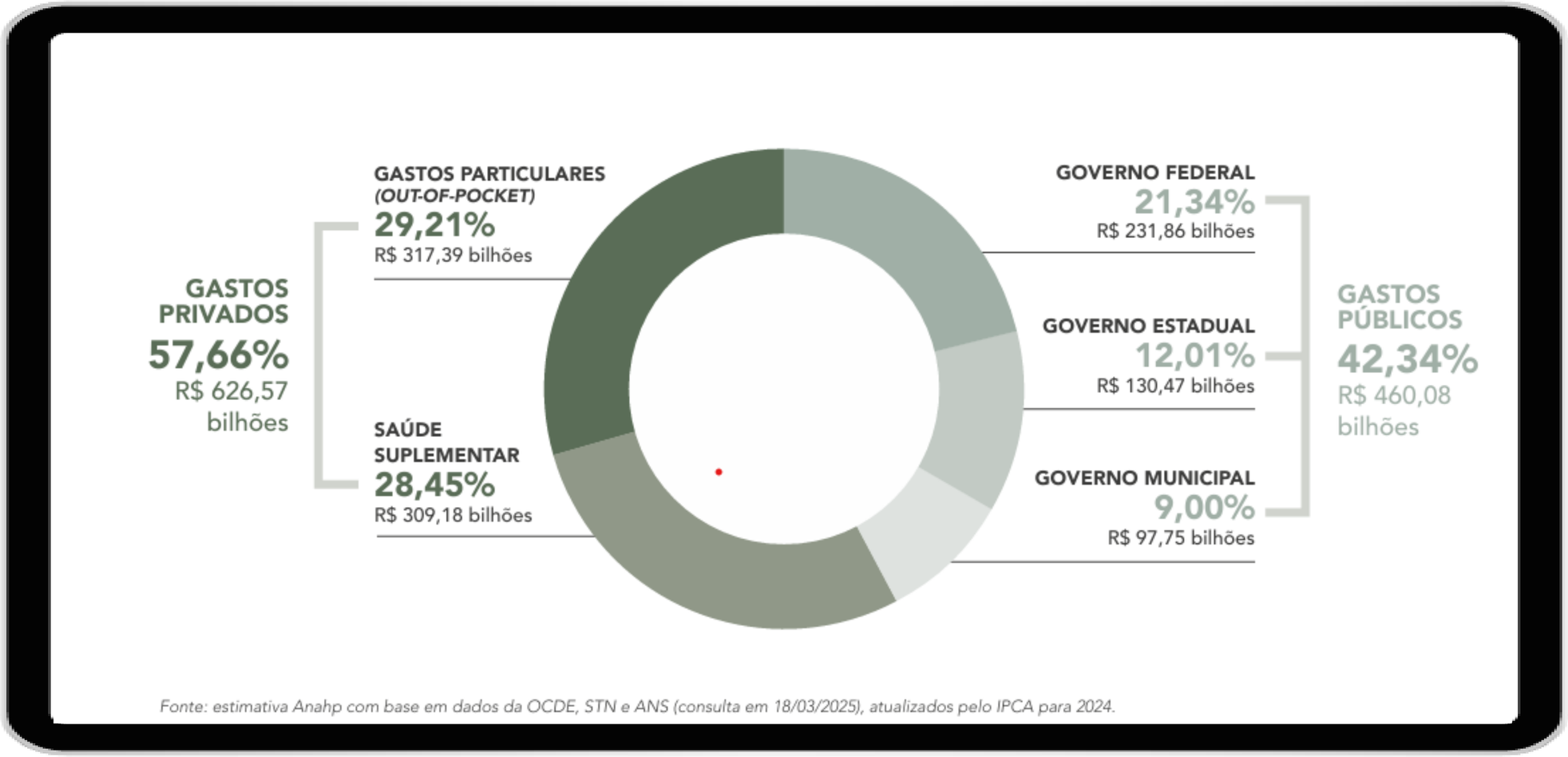
Gastos do governo com saúde / PIB (%)

China – 2,95
Brasil – 4,1
Chile – 5,08
Colombia – 5,4
Estados Unidos – 9,1
Alemanha – 10,13

Fonte: World Bank Group

MERCADO DE SAÚDE

Dados 2024 – Despesas com Saúde no Brasil (R$ 1,08 trilhão – 9,25% do PIB)



Fonte: Observatório ANAHP 2025

MERCADO DE SAÚDE

Principais participantes do mercado de saúde suplementar

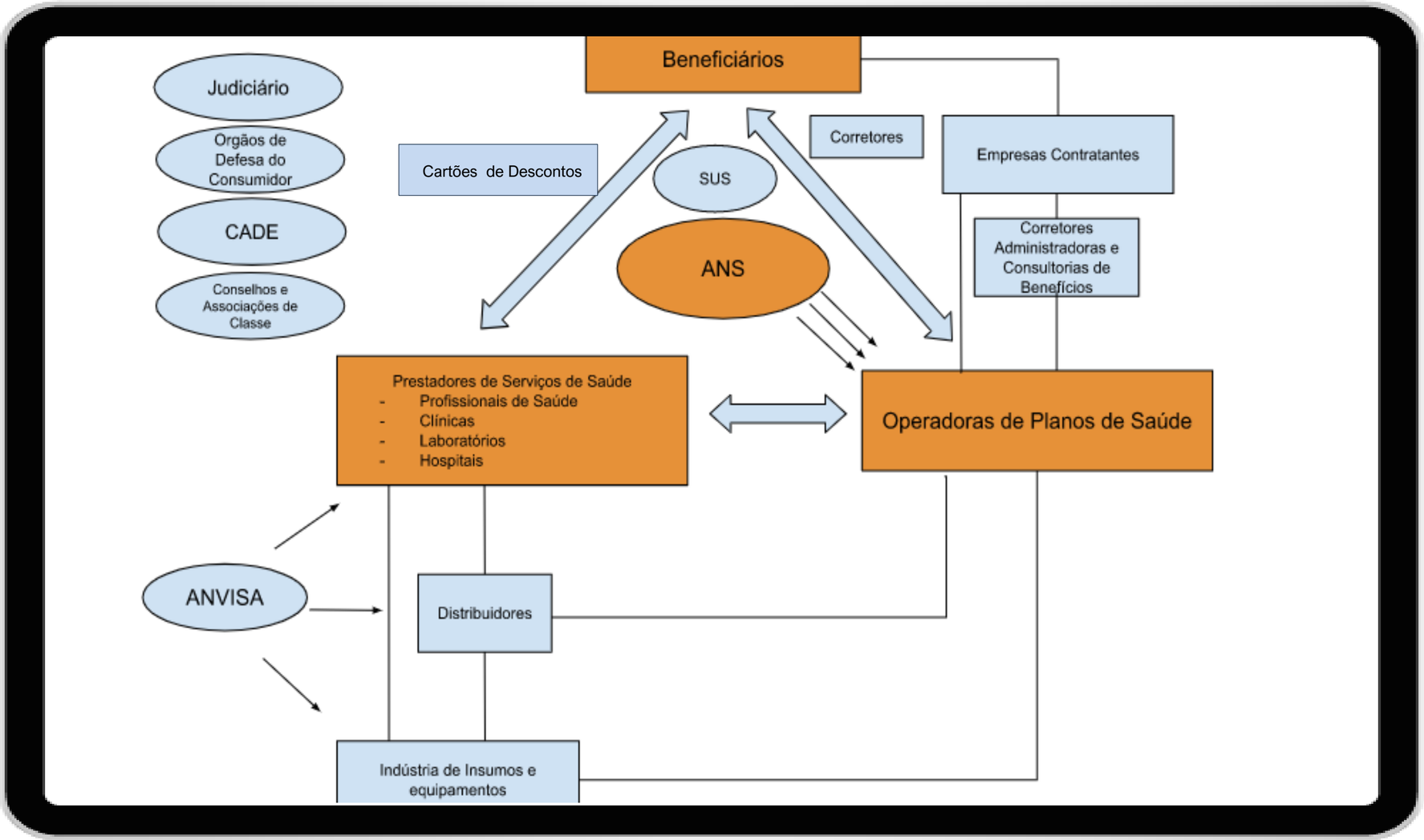
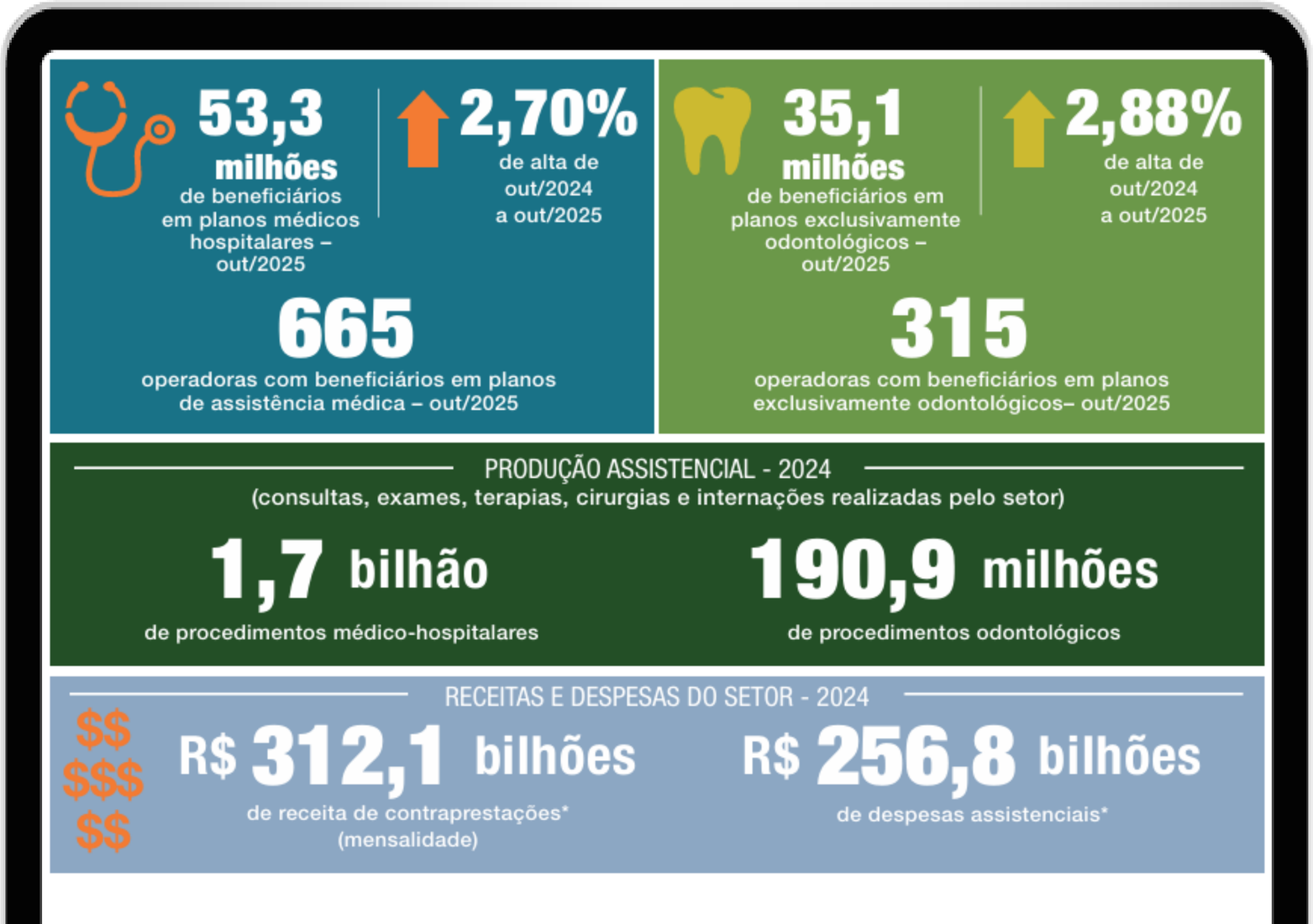


Figura adaptada do livro Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústria da Saúde – Referência Bibliográfica do curso

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – 2024/25

Grandes Números do Setor



Fonte ANS : https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/publicacoes/Panorama_Saude_Suplementar_Ed_10_nov_2025_r05.pdf

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Abril/2025 – Maiores números desde a origem da Saúde Suplementar

52,3MM

em Planos de Assistência Médica

94% planos novos
40% nas medicinas de grupo
25% taxa de cobertura

34,8MM

em Planos exclusivos odontológicos

99% planos novos
38% nas odontologias de grupo
16% taxa de cobertura

30%

da população do Brasil possui algum plano de saúde
(médico ou odontológico)

Grande variabilidade nas taxas de cobertura dos planos de assistência médica entre:

- **capital** (43%) e **interior** (21%)
- **regiões** (Sudeste 30% e Norte 9,7%)
- **estados** (40,5% no estado de SP e 4,8% em Roraima)
- **Municípios** (Vitória 66,5% e Curitiba 55,6%)

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

MEDICINA DE GRUPO 40% dos beneficiários e 28% das despesas assistenciais

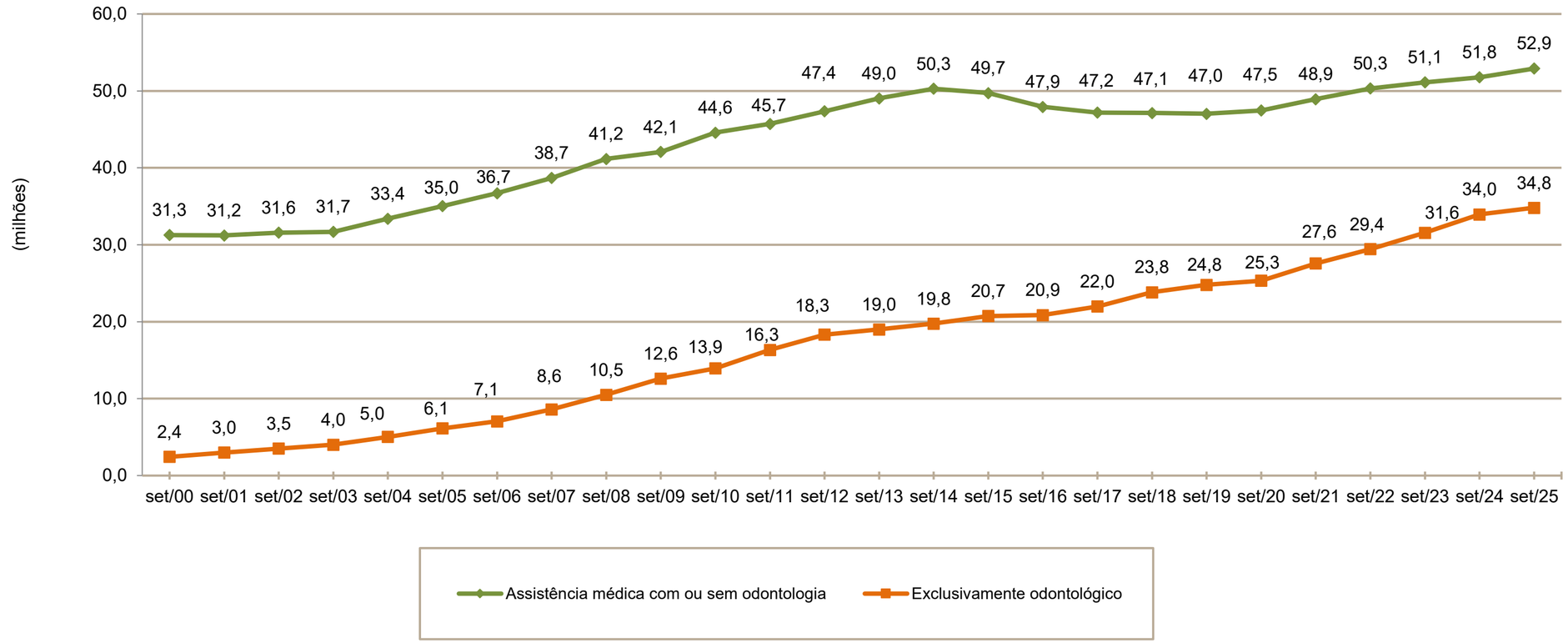
COOPERATIVA MÉDICA 36% dos beneficiários e 32% das despesas assistenciais

Essas variações dependem de **características dos produtos e da operação como rede, mecanismos de regulação, presença ou não de reembolso**, entre outros, incluindo a **verticalização**

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Crescimento atingindo maiores números desde a origem da saúde suplementar

Beneficiários de Planos de Saúde
Brasil 2000 - 2025

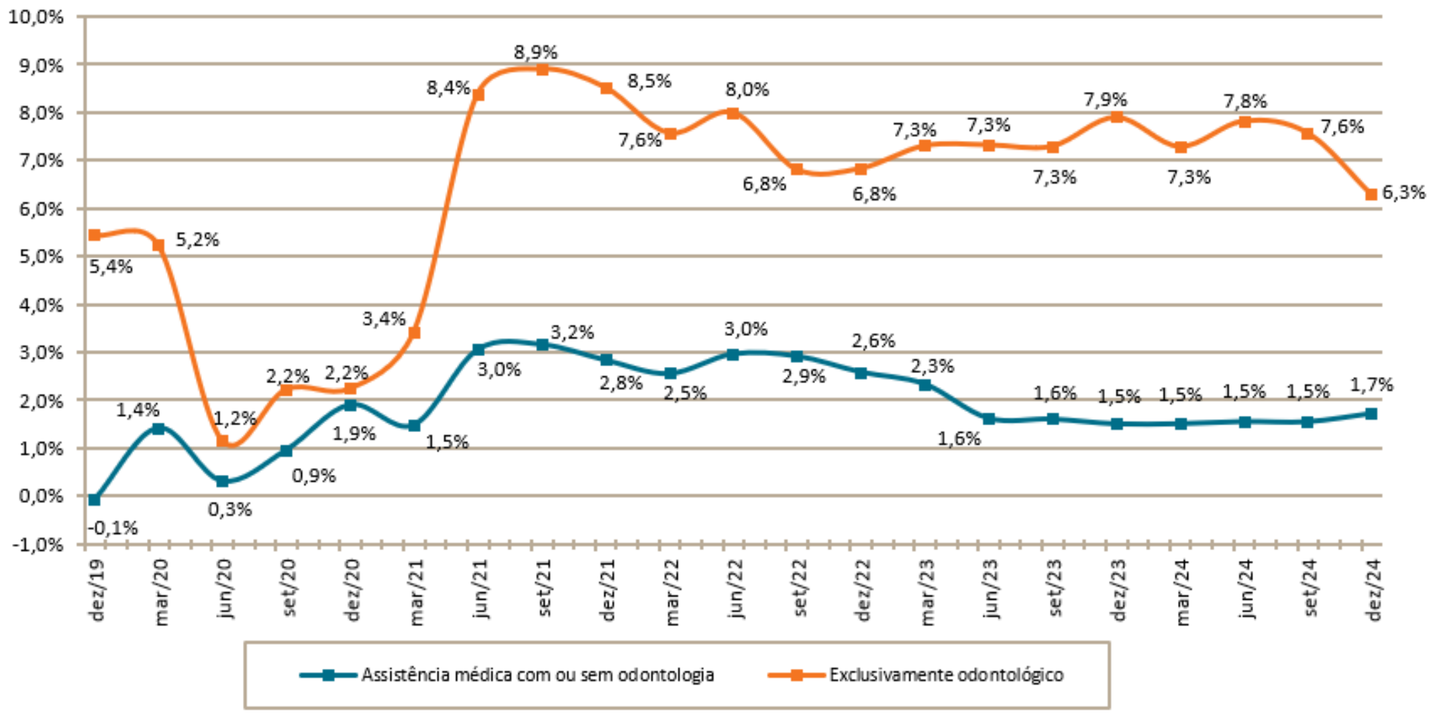


Fonte: ANS
Dados Consolidados da Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Maiores taxas de crescimento continuam ocorrendo nos planos exclusivamente odontológicos

Taxa de crescimento anual do número de beneficiários de planos de saúde, por cobertura assistencial (Brasil dez/2019-dez/2024)



Fonte:SIB/ANS/MS - 01/2025
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2025
Notas: 1. O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
2. Dados preliminares, sujeitos a revisão.

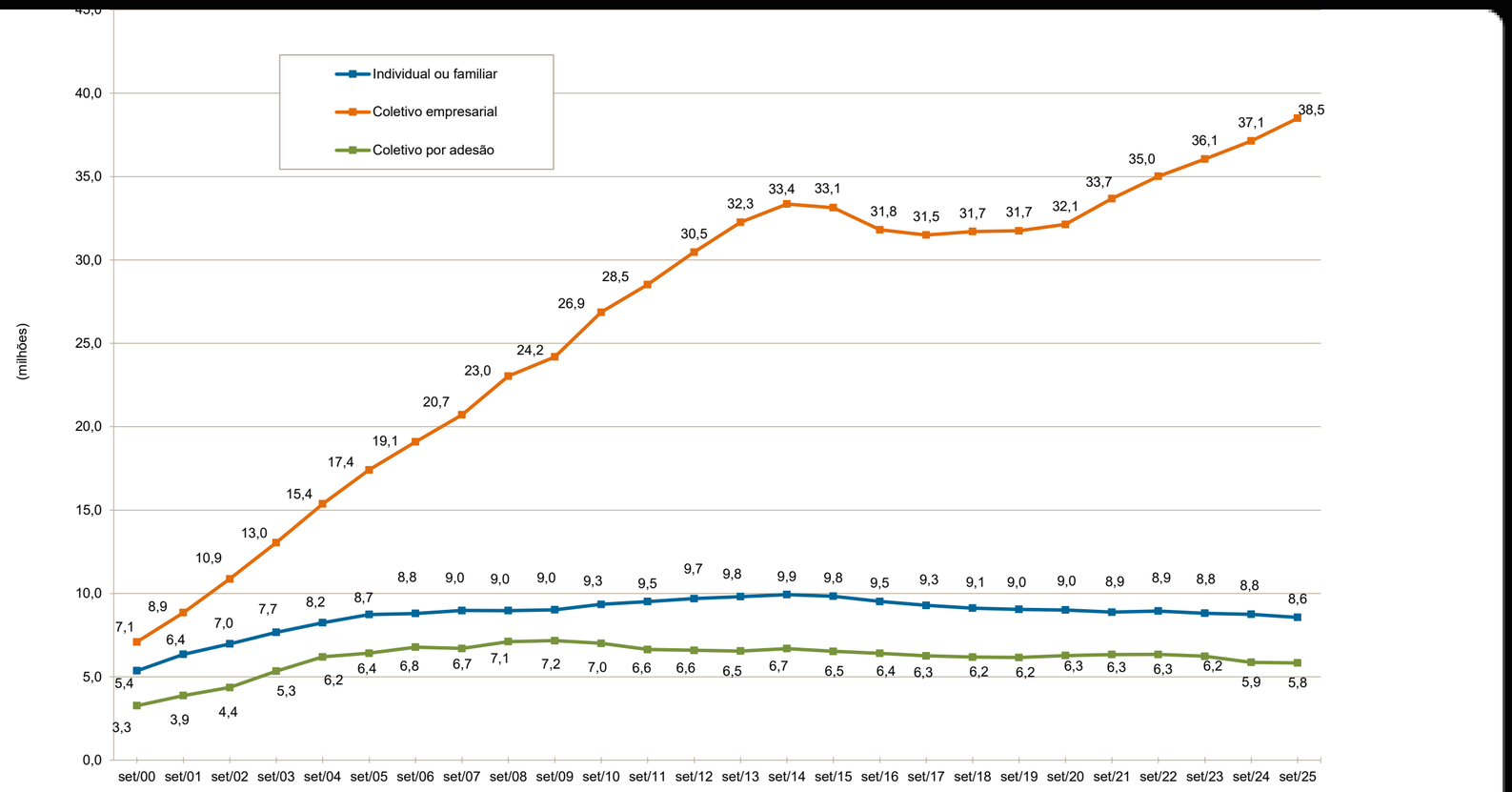
Fonte: ANS
Caderno de Informações da Saúde Suplementar – mar25

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Aumento significativo dos planos coletivos (representam 83%) e redução dos planos individuais ou familiares (representam 16,2%)

Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação

Brasil 2000-2025



Nota: Os tipos de contratação classificados como “Coletivo não identificado” e “Não informado” foram omitidos do gráfico

Fonte: ANS
Dados Consolidados da Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Redução do número de beneficiários nos planos individuais ou familiares

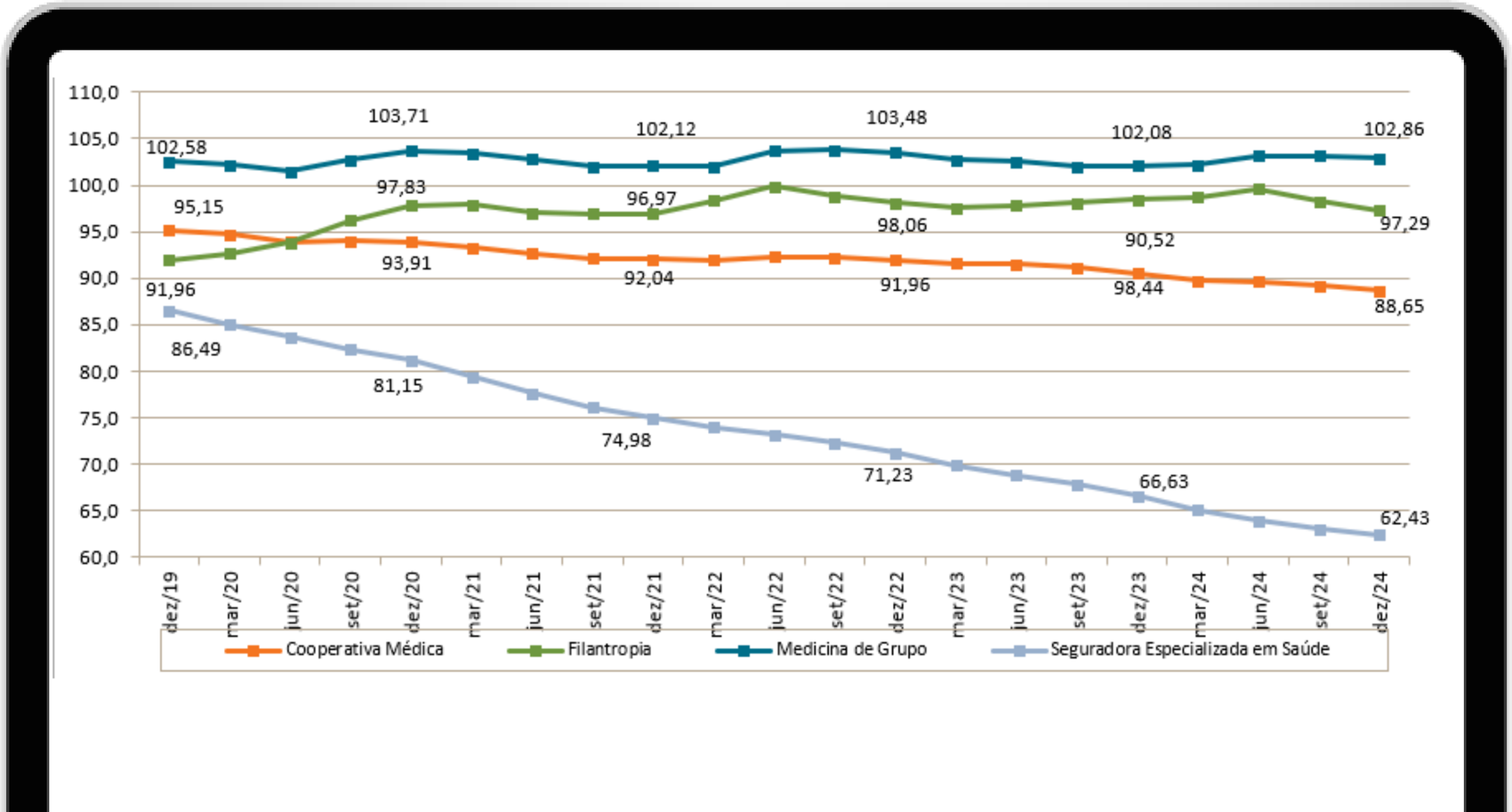
Nas seguradoras essa redução chegou a 37,6% do número de 2016

Nas medicinas de grupo o crescimento atingiu 4% em 2022 – discreta redução posterior

Número-índice de beneficiários em planos individuais, segundo a modalidade da operadora

(Brasil – setembro/2018 – setembro/2023)

100% número de beneficiários em 2017



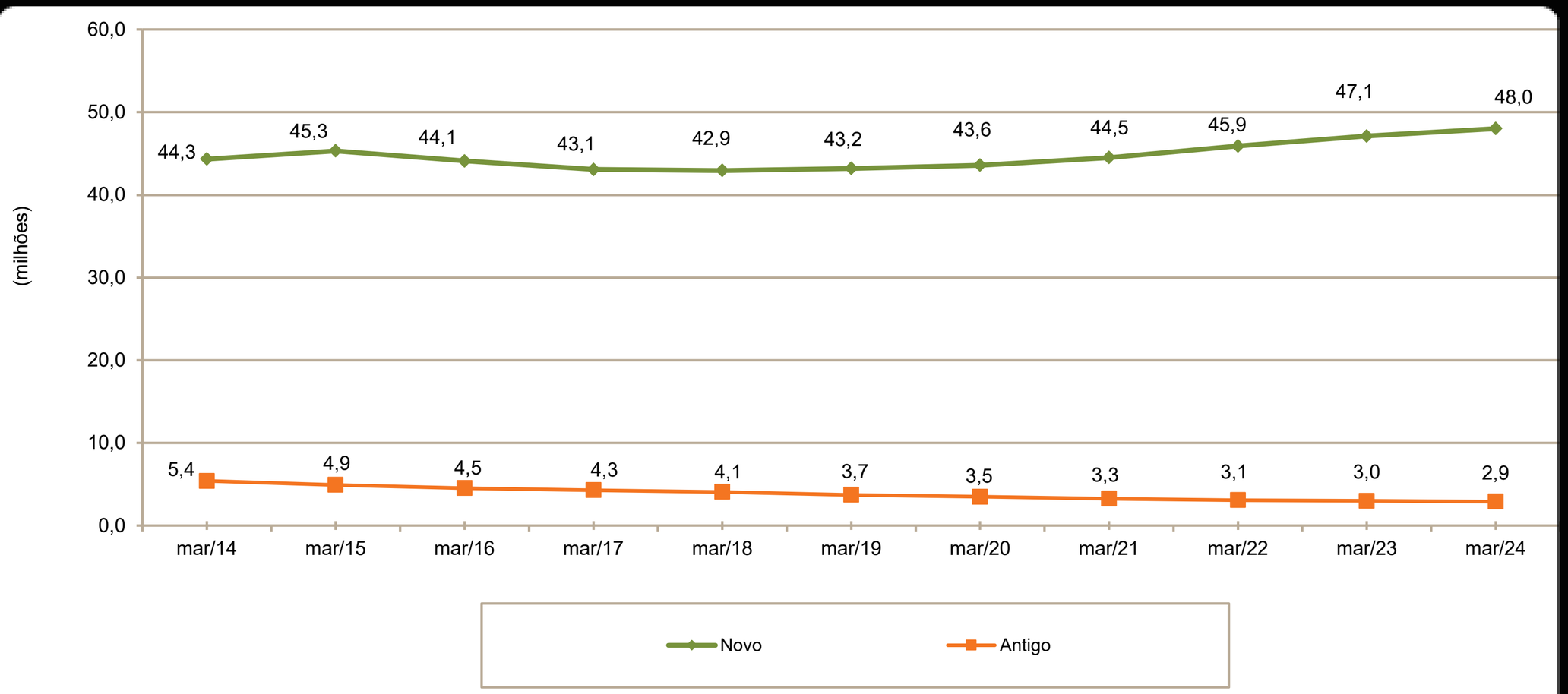
Fonte: ANS
Caderno de Informações da Saúde Suplementar – mar25

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

94% Planos Novos

Beneficiários de planos de assistência médica por época de contratação

Brasil 2014-2024



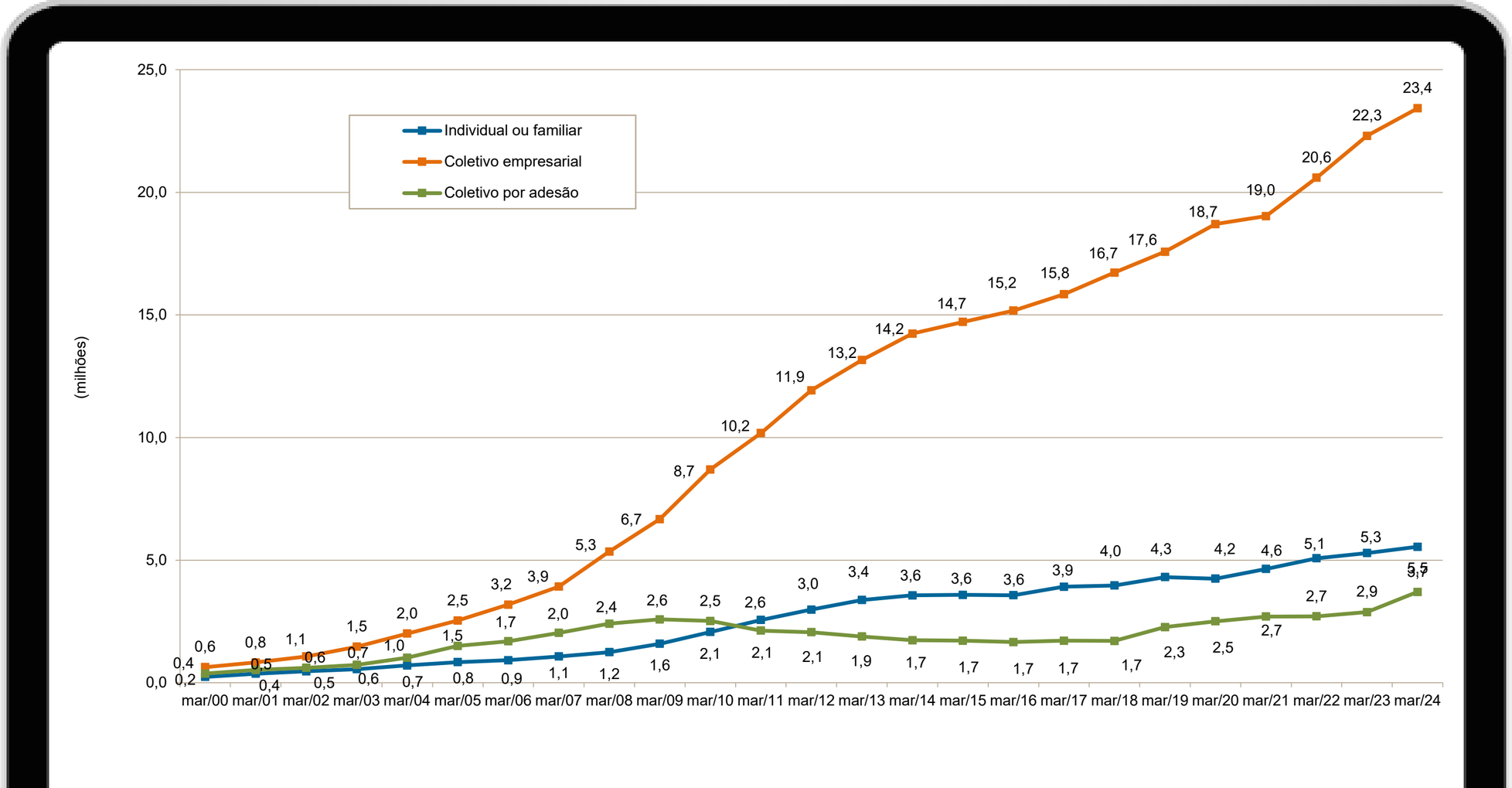
Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Aumento significativo dos planos coletivos

Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo de contratação

Brasil 2000-2024

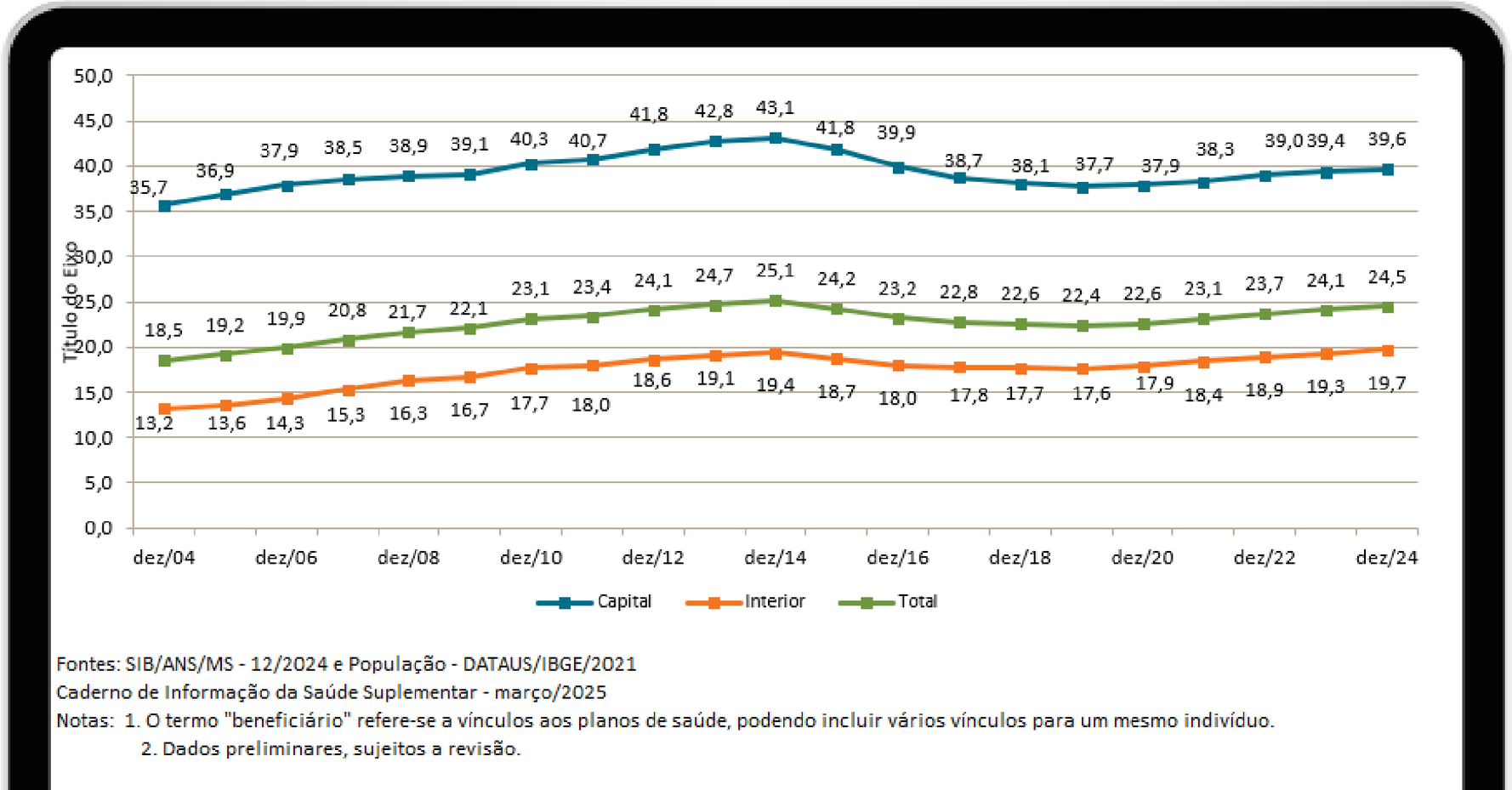


Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Aumento na taxa de cobertura dos planos de assistência médica
Grande variabilidade na taxa de cobertura entre capital e interior

Taxa de cobertura dos planos de assistência médica, por localização
(Brasil – dez/2004 – set/2023)



Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2024 e População - DATAUS/IBGE/2021
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2025
Notas: 1. O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
2. Dados preliminares, sujeitos a revisão.

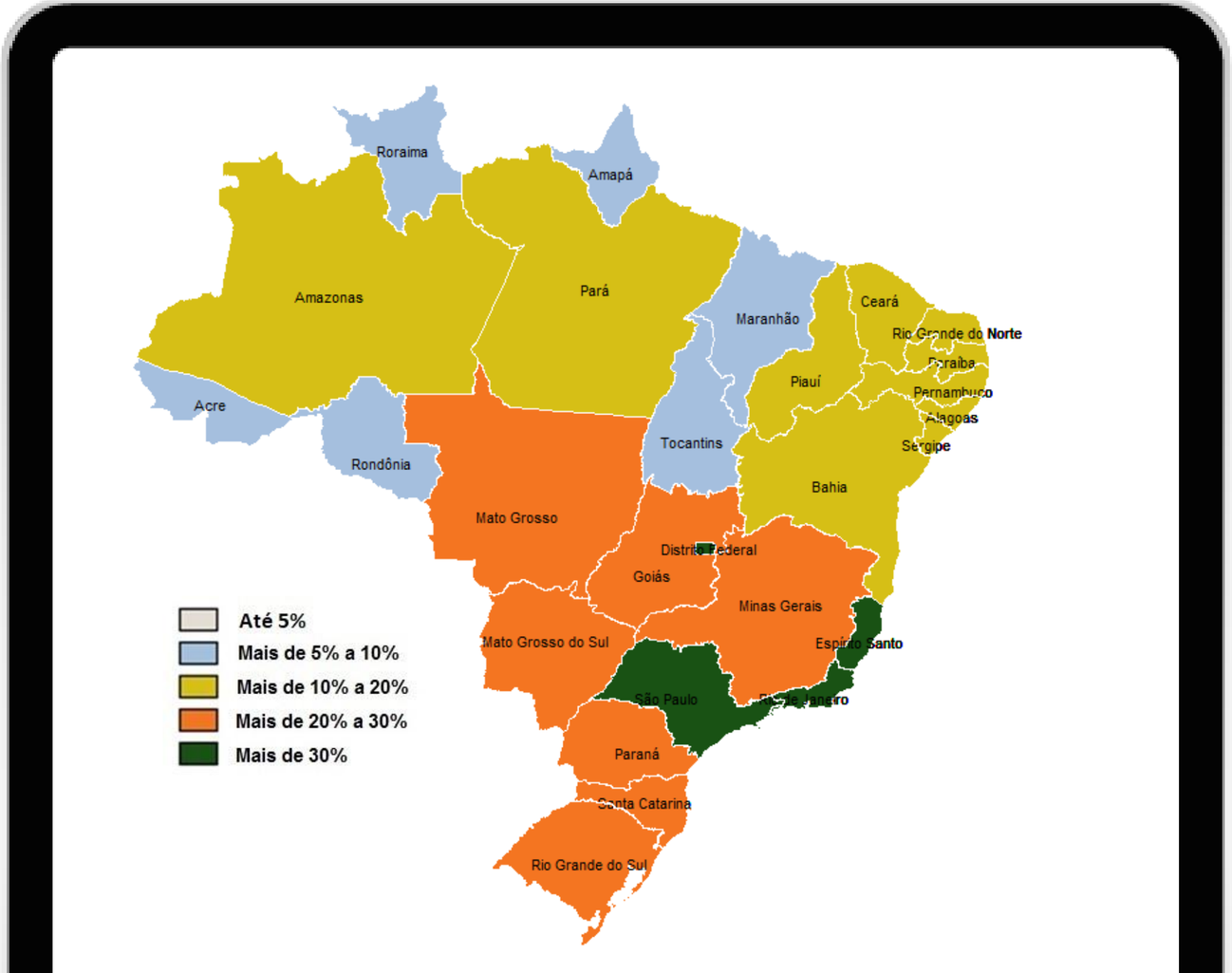
Fonte: ANS
Caderno de Informações da Saúde Suplementar – mar25

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Aumento na taxa de cobertura dos planos de **assistência médica**

Variabilidade entre regiões:
Sudeste – 30% e Norte - 9,7%
Grande variabilidade entre estados
40,5% no estado de SP e
4,8% em Roraima

Taxa de cobertura dos planos de assistência médica, por localização
(Brasil – Maio/2024)



Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

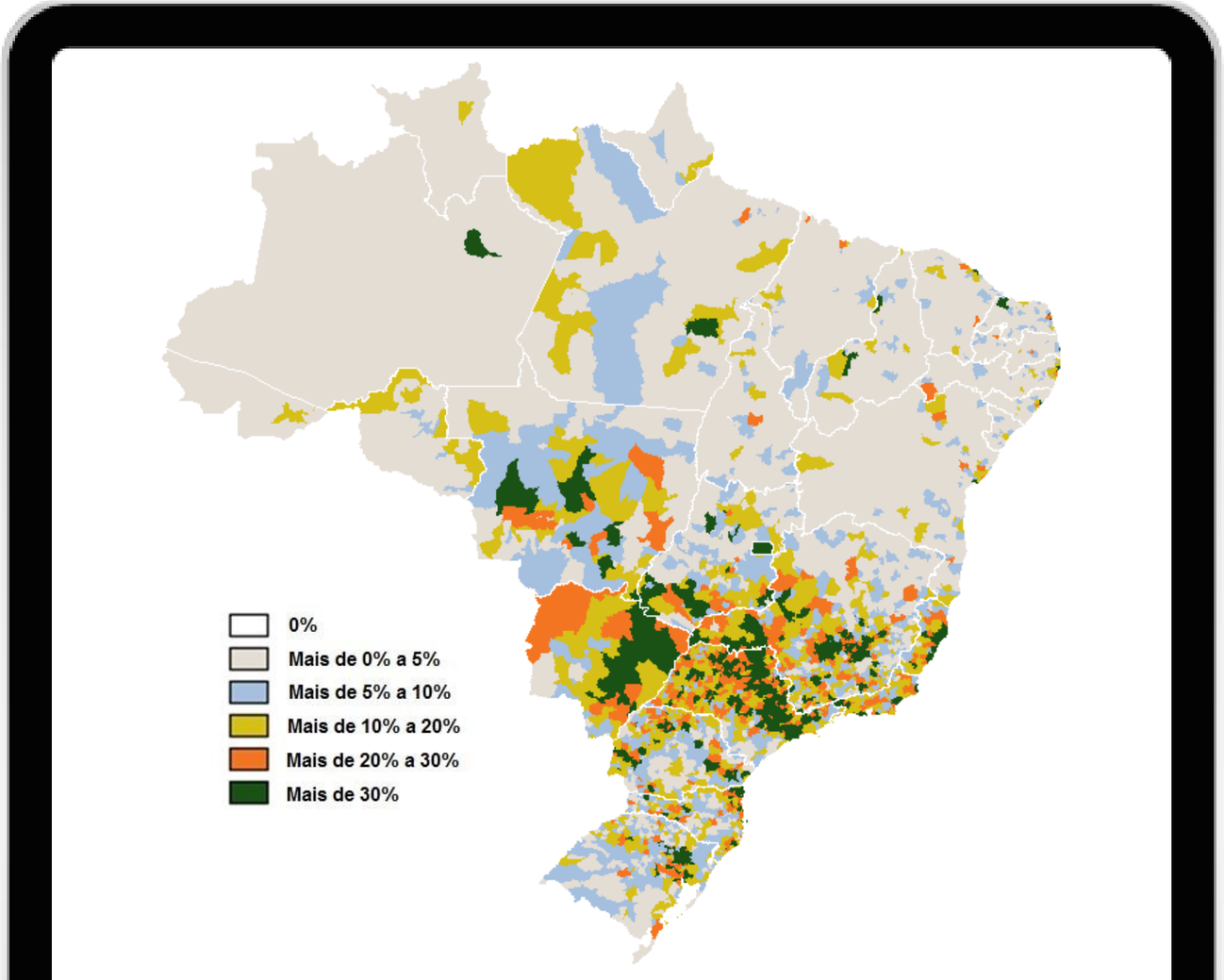
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Aumento na taxa de cobertura dos planos de assistência médica

Grande Variabilidade também entre municípios

Vitória 66,5% e Curitiba 55,6%

Taxa de cobertura dos planos de assistência médica, por localização
(Brasil – Maio/2024)



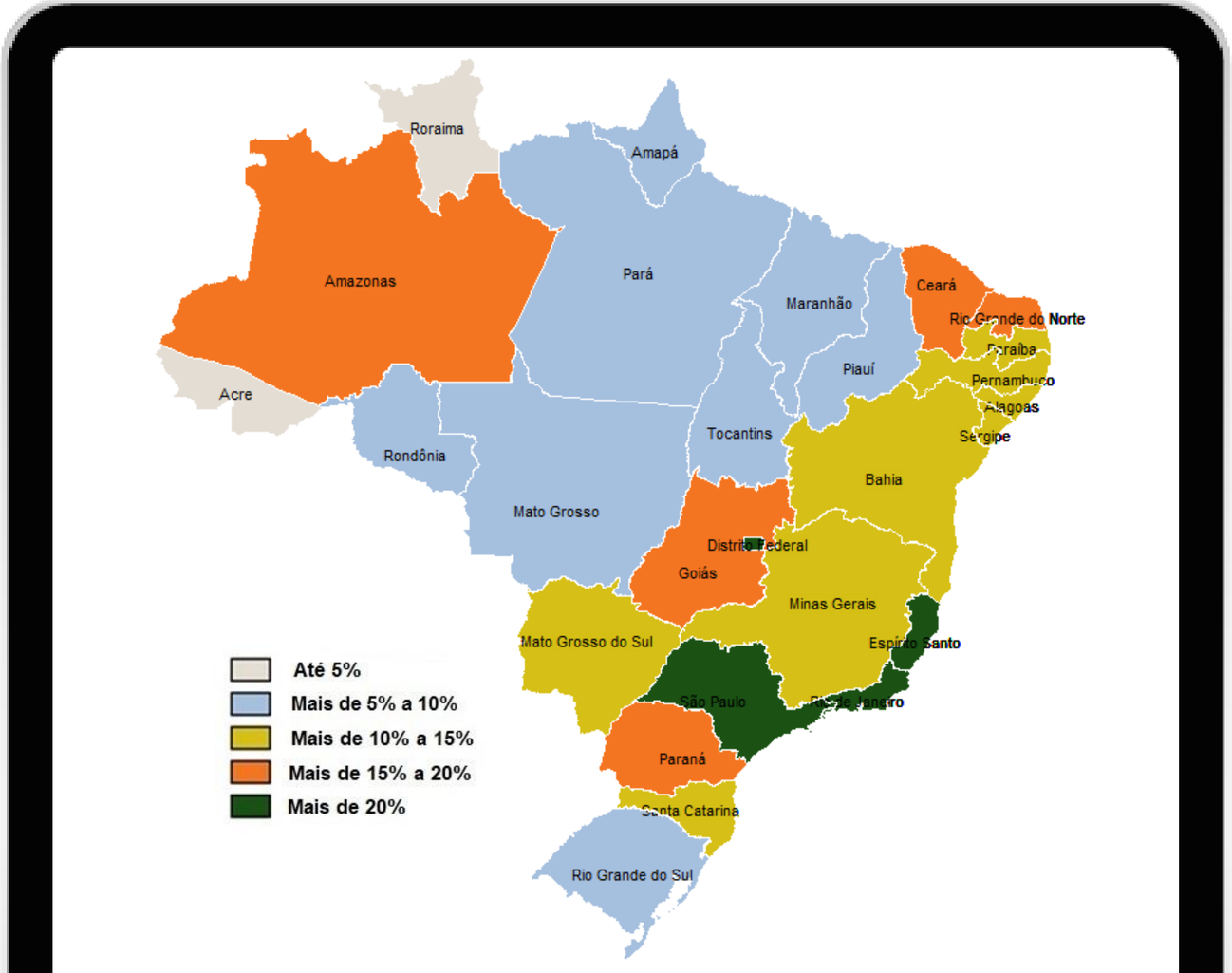
Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Taxa de cobertura dos planos **exclusivamente odontológicos** ainda inferior, mas em **ritmo crescente**

Grande variabilidade entre regiões e grande variabilidade entre estados

Taxa de cobertura dos planos exclusivamente odontológicos, por localização (Brasil – Maio/2024)



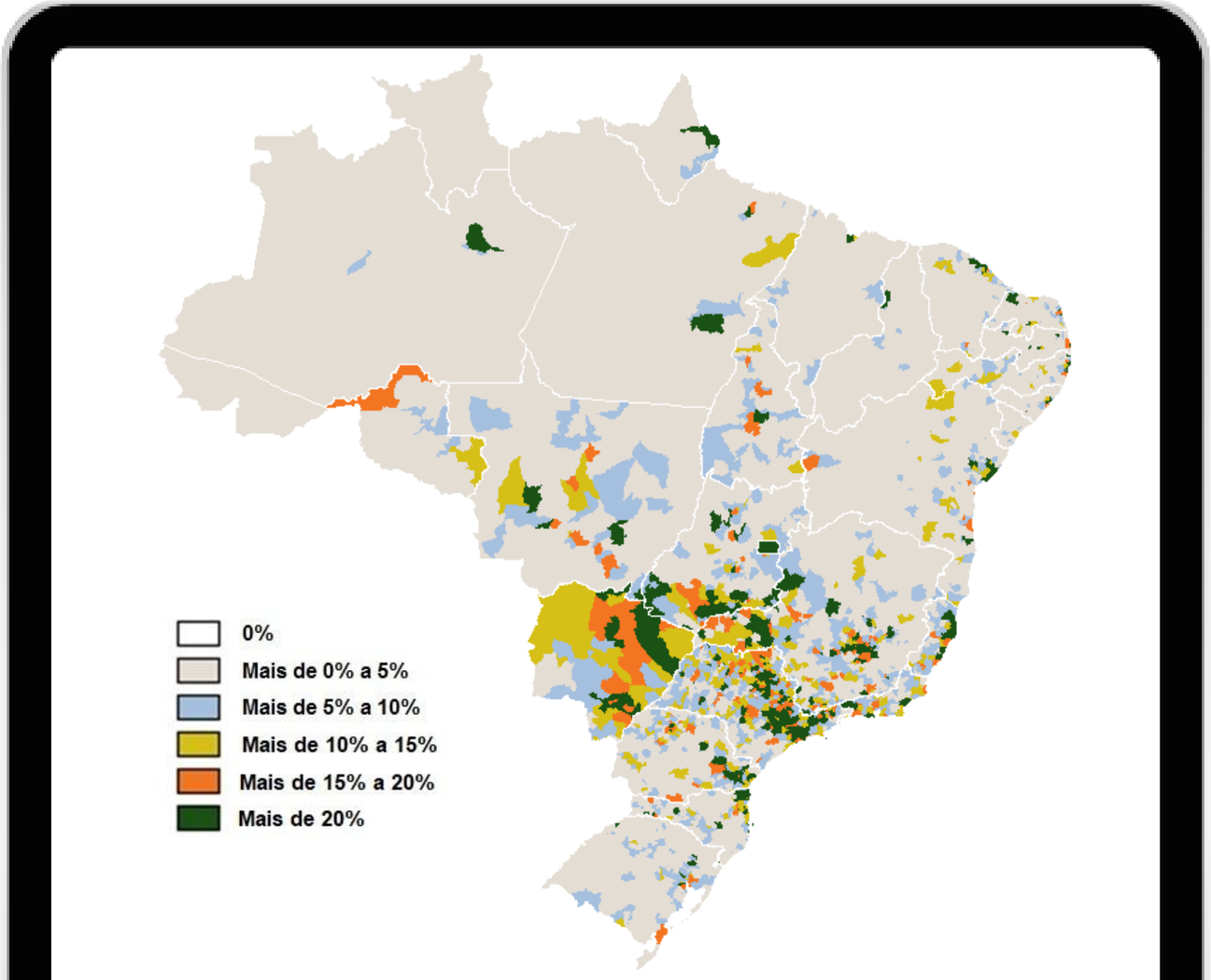
Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Taxa de cobertura dos planos **exclusivamente odontológicos** ainda inferior aos planos de médico-hospitalares

Grande variabilidade entre regiões e grande variabilidade entre municípios

Taxa de cobertura dos planos exclusivamente odontológicos, por localização (Brasil – Maio/24)



Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

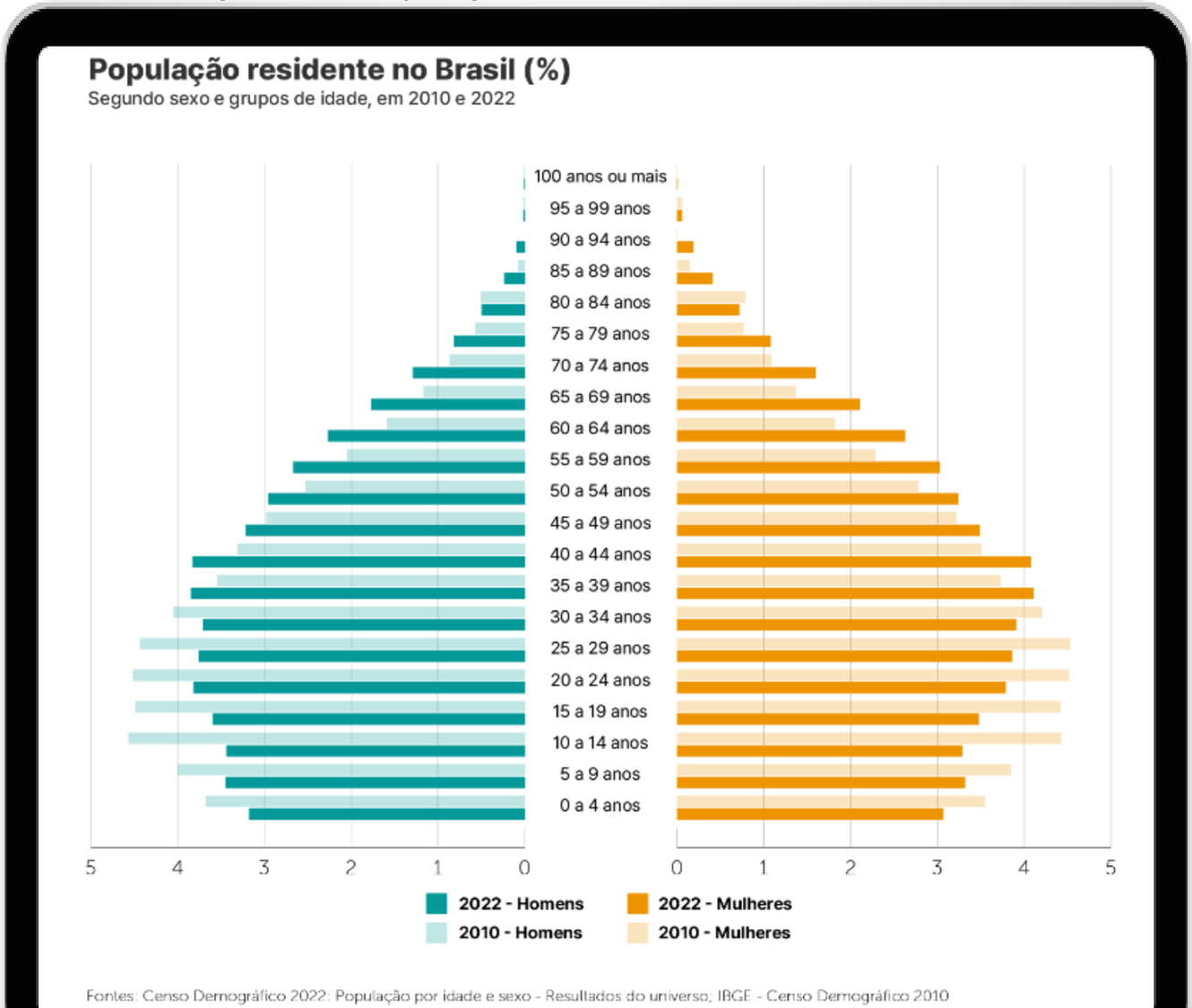
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (R$)

Dados 2021, 2022, 2023 e 2024

2021	2022	2023	2024
206 BILHÕES em despesas assistenciais	**208,2 BILHÕES** Aumento 1%	**239,3 BILHÕES** Aumento 15% Aumento frequência, custos assistenciais, tecnologias	**257 BILHÕES** Aumento 6% Enorme controle das operadoras, descredenciamentos, cancelamentos de planos
239 BILHÕES de receita em contraprestações	**237,6 BILHÕES** Redução 1% Downgrade de planos	**275,0 BILHÕES** Aumento 16% reajustes expressivos	**309 BILHÕES** Aumento 10% reajustes expressivos

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Distribuição Etária População Brasileira – Evolutivo – 2010 a 2022

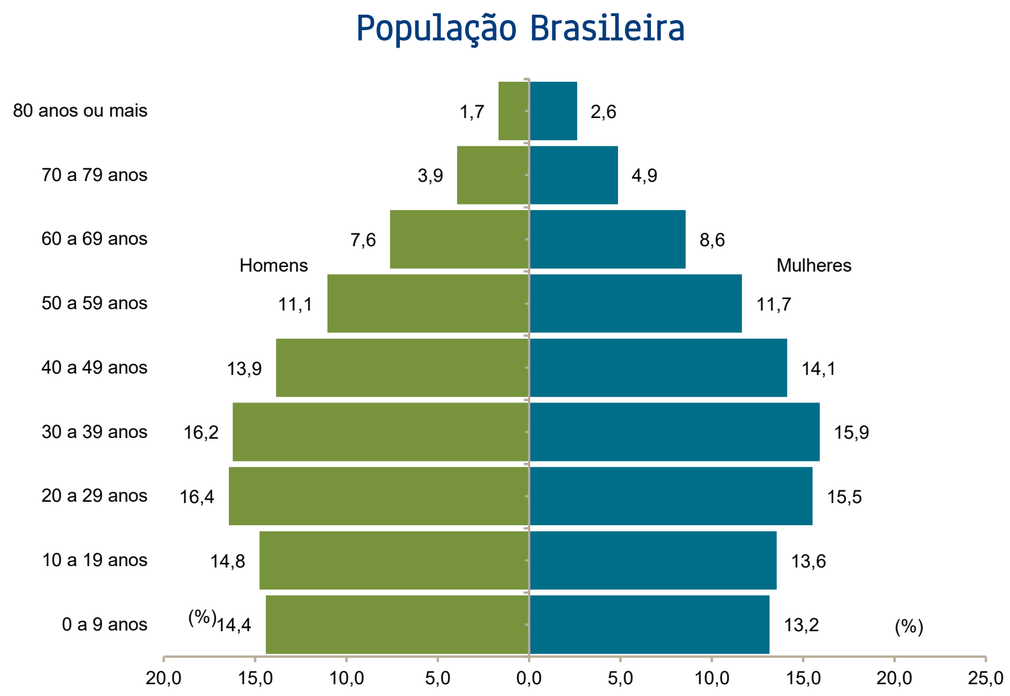


Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html

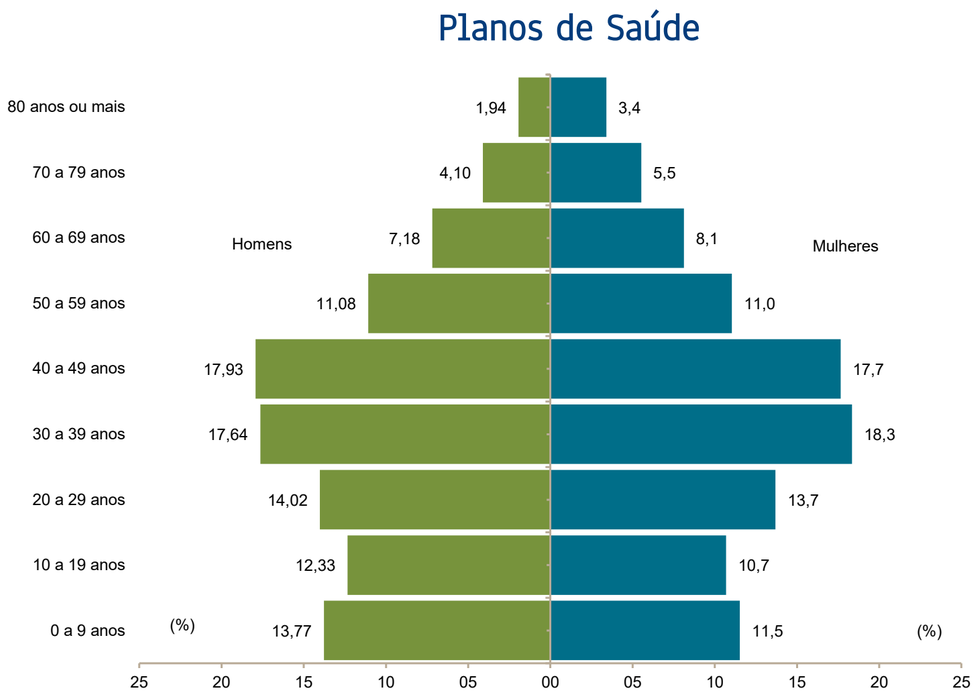
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Distribuição Etária dos beneficiários de Planos de Saúde comparada à da população brasileira

Out/2023



Fonte: População - IBGE/DATASUS/2021



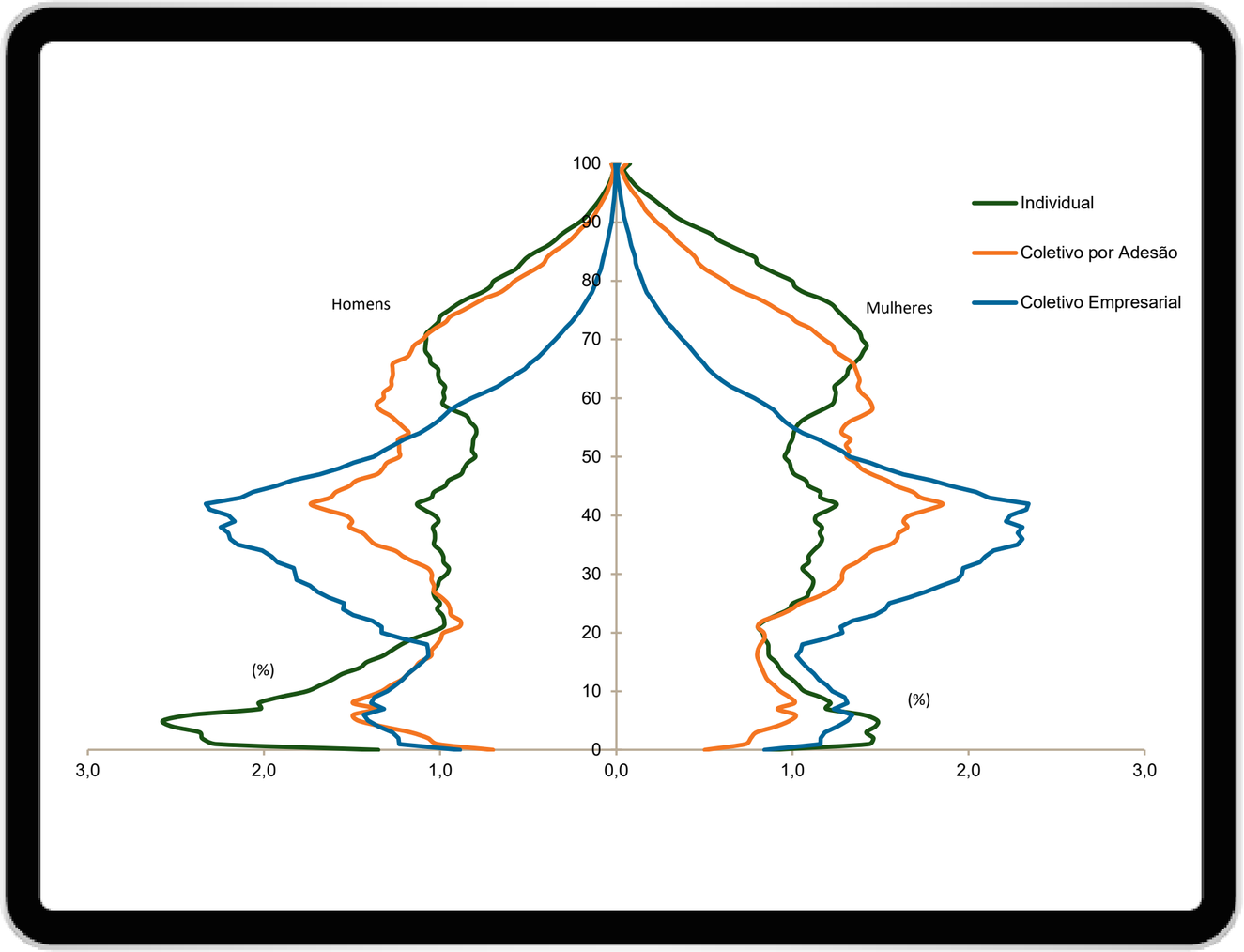
Fonte: SIB/ANS/MS – 11/2025

Maior Concentração entre 20 e 50 anos – acompanhando mercado de trabalho

Maior necessidade de cuidados com saúde – faixa etária mais elevada

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Distribuição Etária dos beneficiários de Planos de Saúde
Mai/24 - Por tipo de Contratação



Maior Concentração entre 20 e 50 anos - acompanhando mercado de trabalho - **Coletivos empresariais**

Concentração nas faixas etárias mais elevadas - **Individuais**

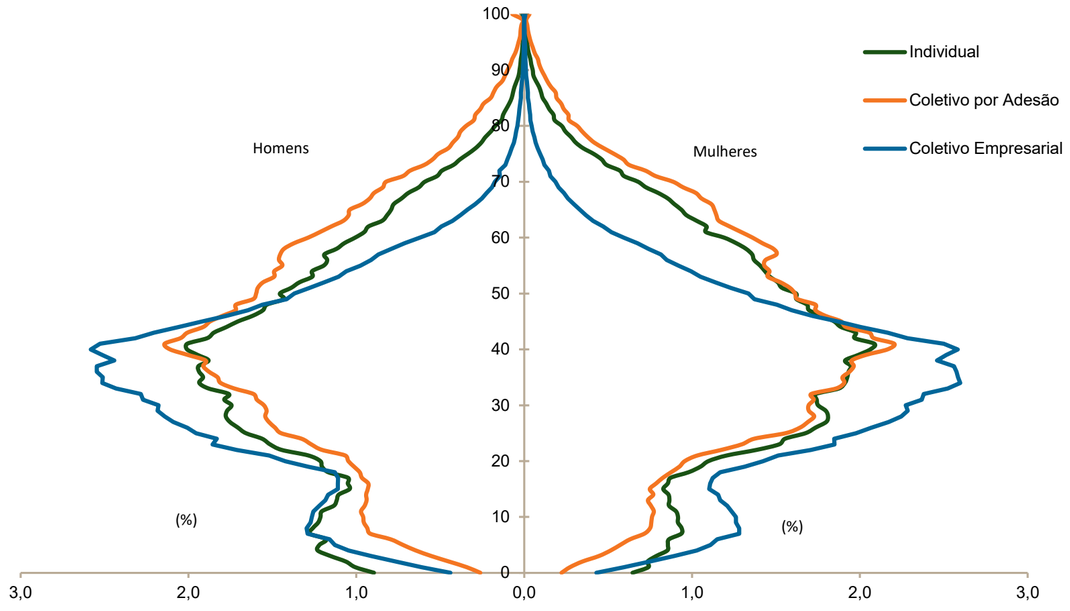
Coletivos por adesão - autônomos, mercado informal, preços inferiores aos individuais

Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

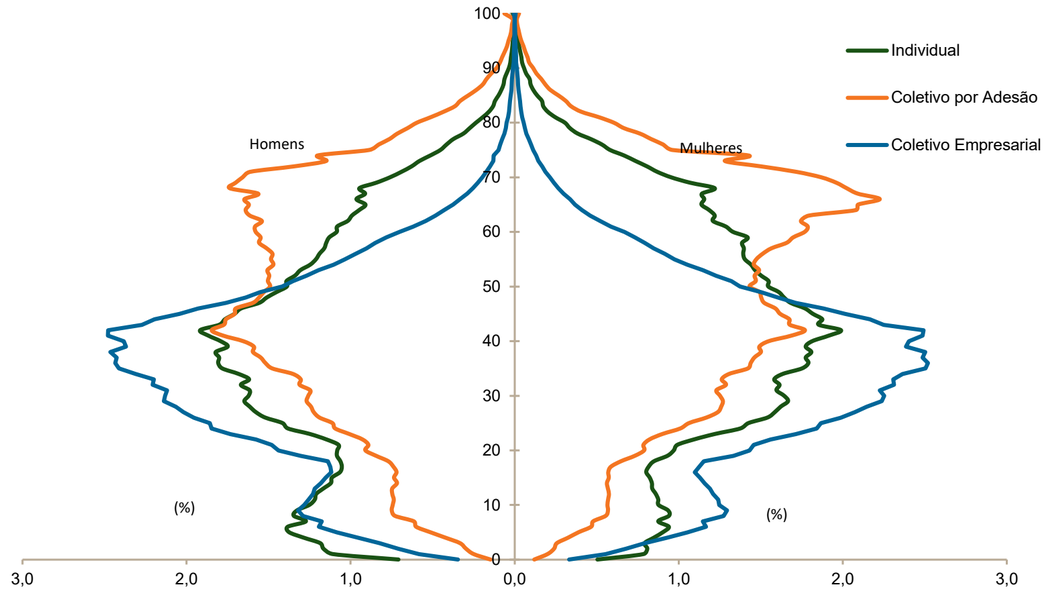
A diferença da distribuição etária entre os tipos de contratação não é tão significativa quanto a dos planos de assistência médica, porém nos últimos 2 anos teve grande alteração nos coletivos por adesão

Distribuição Etária dos beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos - Dez/22 – Por tipo de Contratação



Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Dez/2022

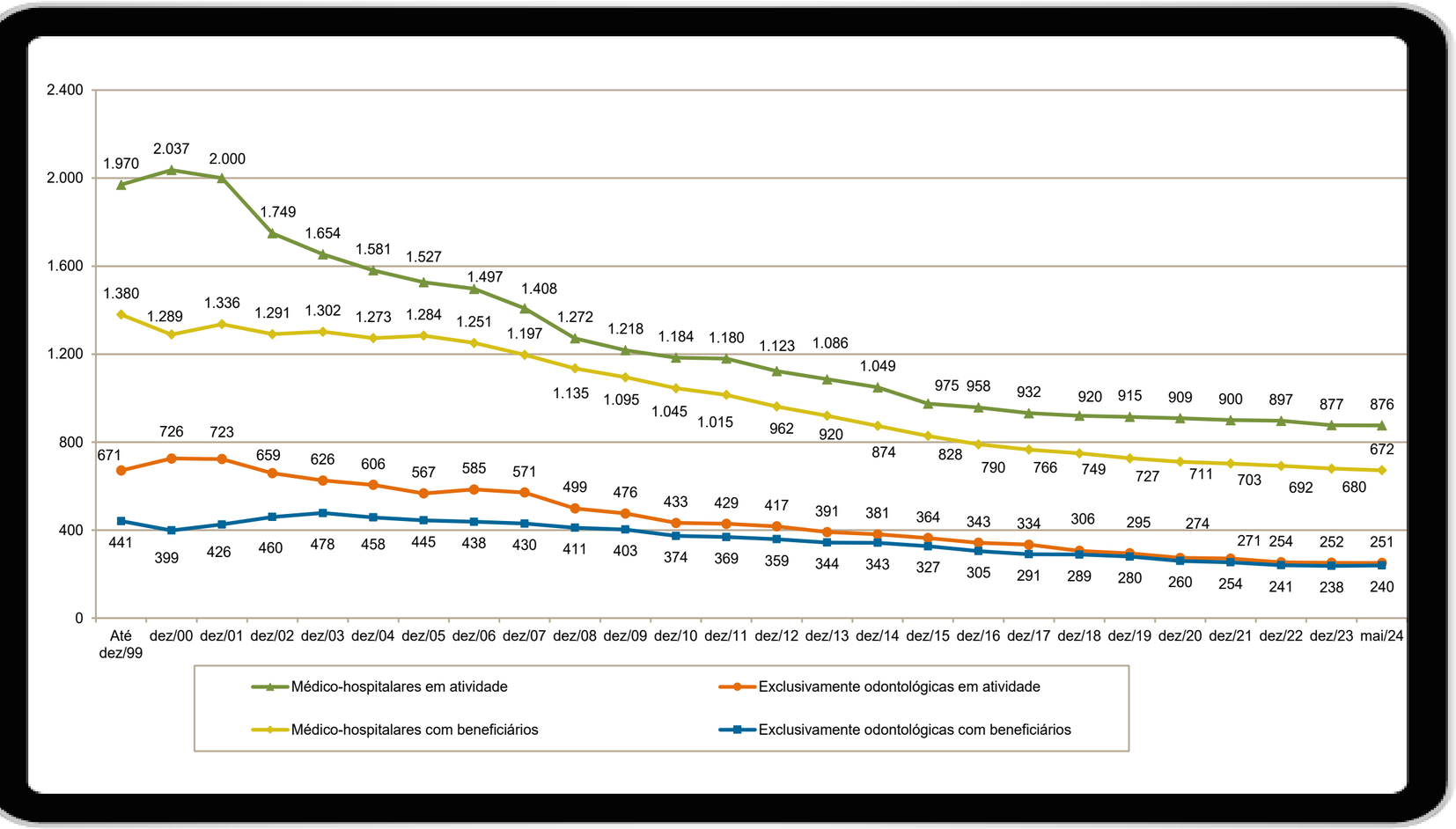
Distribuição Etária dos beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos - Mai/24 – Por tipo de Contratação



Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Concentração/Consolidação
do setor das operadoras



Forte regulação para garantia da segurança dos consumidores

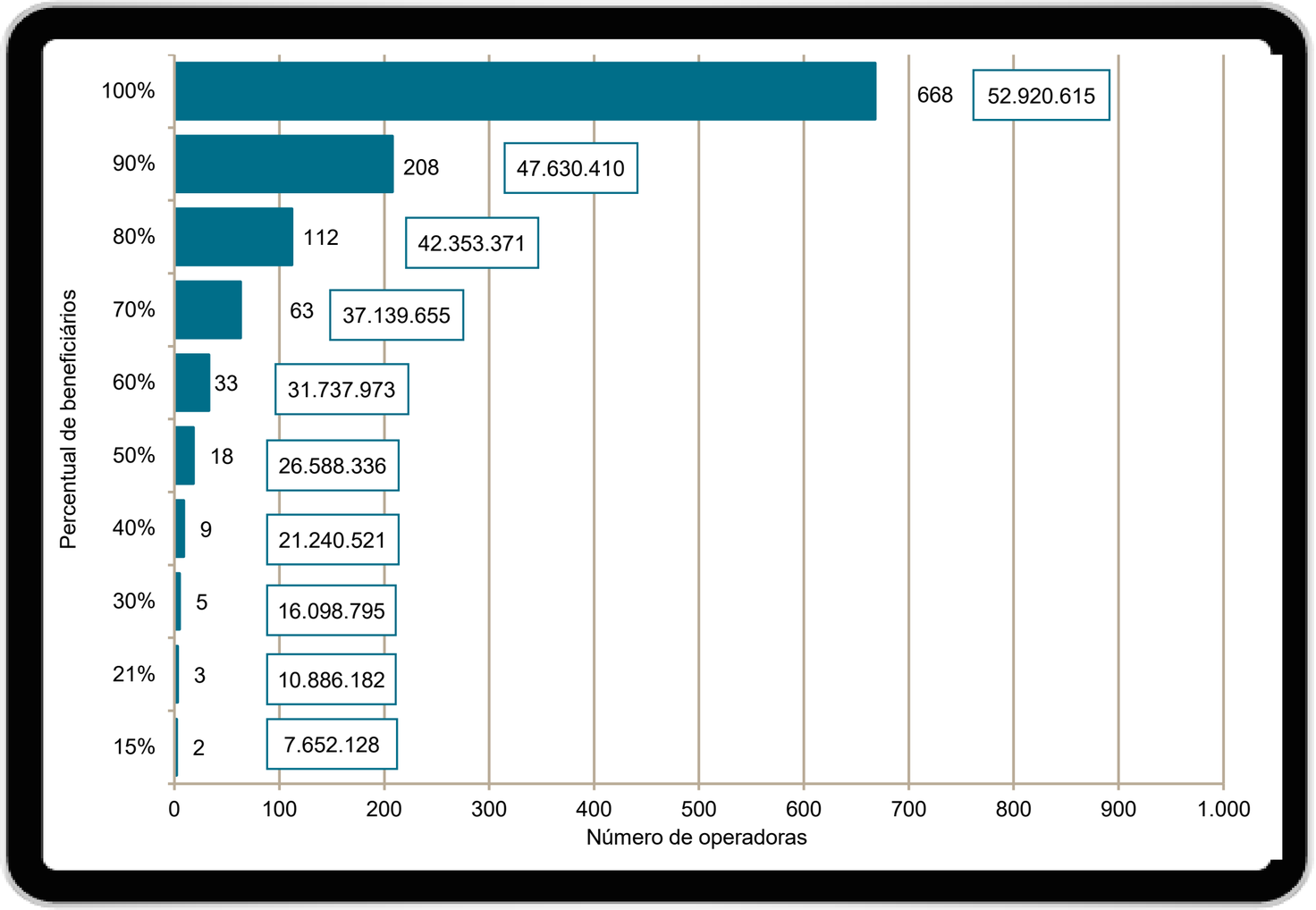
Muitas operadoras não possuíam condições de atividade, garantias financeiras (redução importante entre 2000 e 2003)

2023: 43% da quantidade de operadoras de assistência médica de 2000

Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Distribuição de beneficiários de planos de assistência médica por operadoras – Nov/25



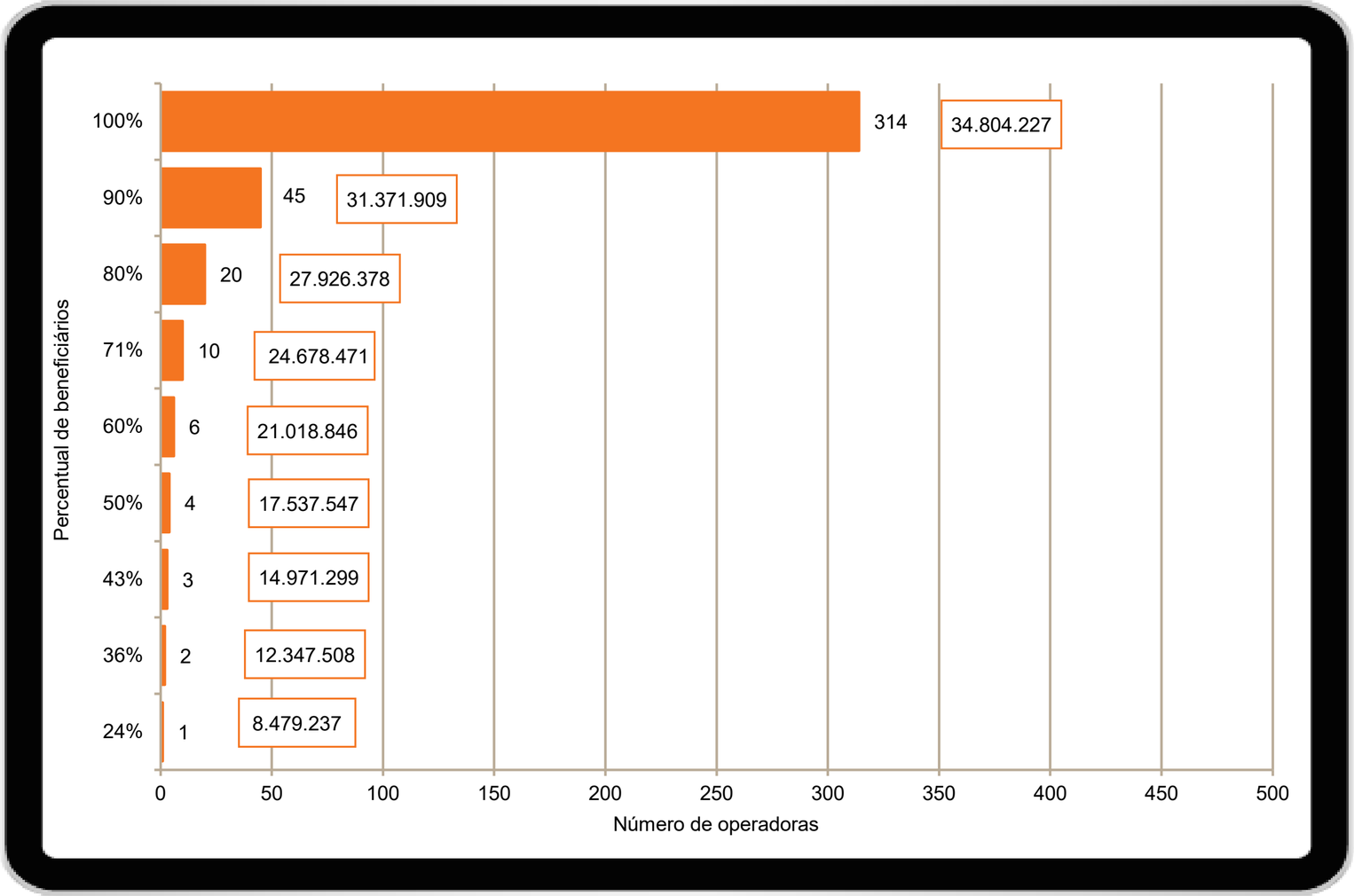
18 (3%) operadoras concentram 50% dos beneficiários de planos de assistência médica

112 (17%) operadoras concentram 80% dos beneficiários de planos de assistência médica

Fonte: ANS
Dados Consolidados da Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Distribuição de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por operadoras – Nov/2025



O mercado odontológico é ainda mais concentrado

4 (1%) operadoras de planos exclusivamente odontológicos concentram 50% dos beneficiários

20 (6%) operadoras de planos exclusivamente odontológicos concentram 80% dos beneficiários

Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

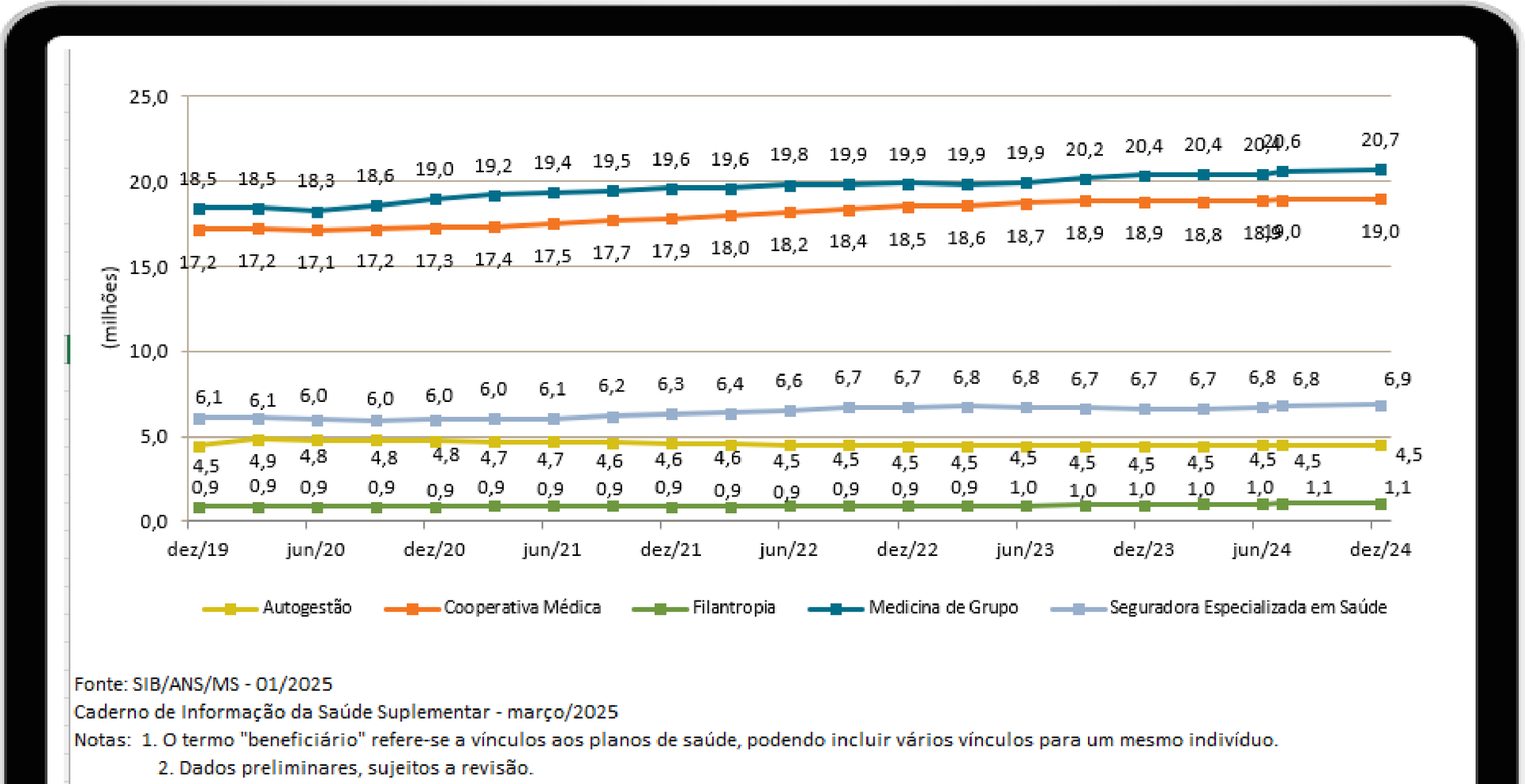
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Medicinas de grupo: operadoras que mais cresceram nos últimos 5 anos e com a maior quantidade de beneficiários

Autogestões encolheram

Beneficiários de planos de assistência médica por modalidade de operadoras

Dez/23



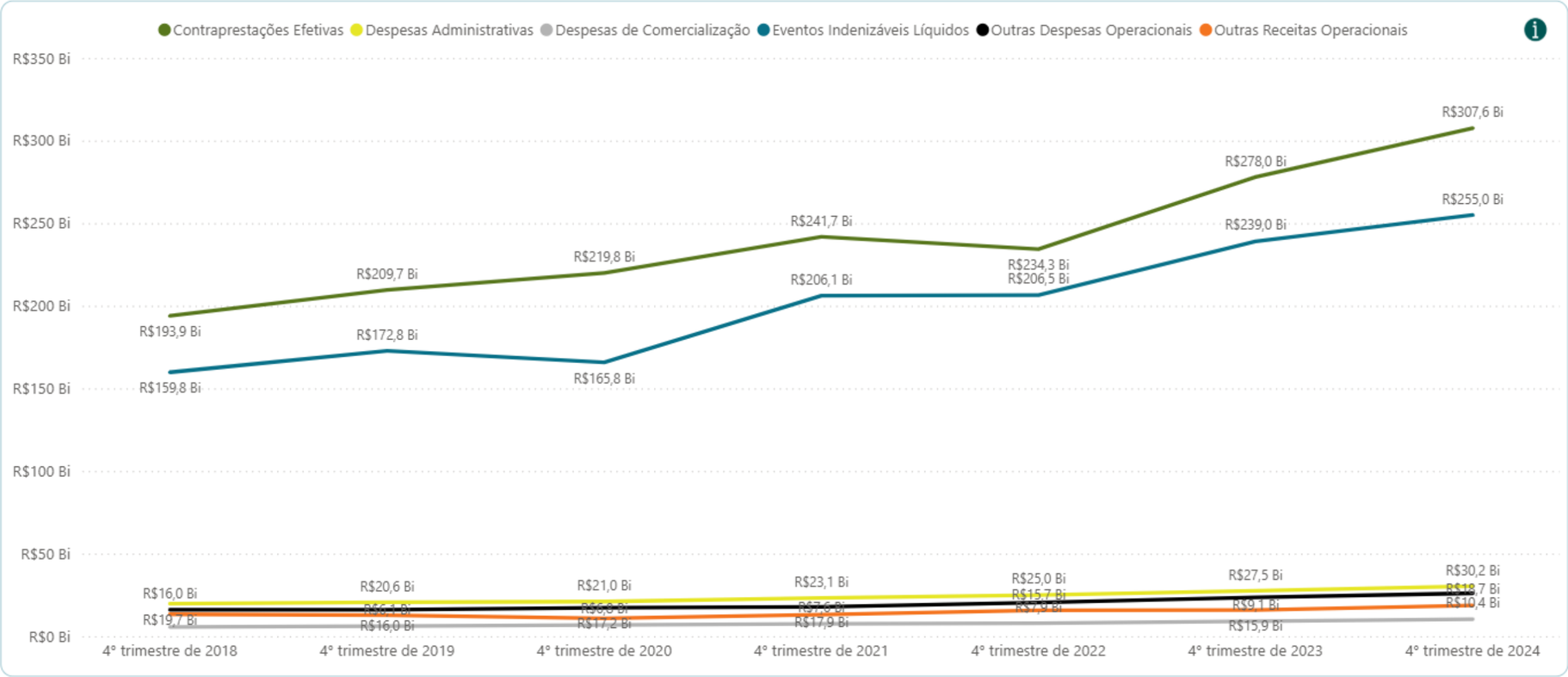
Fonte: SIB/ANS/MS - 01/2025
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2025
Notas: 1. O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
2. Dados preliminares, sujeitos a revisão.

Fonte: ANS
Caderno de Informações da Saúde Suplementar – mar25

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Elevado movimento financeiro das operadoras médico-hospitalares e necessidade da manutenção e sustentabilidade do setor de saúde suplementar para a saúde no Brasil, seja para beneficiários, prestadores de serviços e para o SUS.

Receitas e despesas - operadoras médico-hospitalares, por tipo
2018-2024



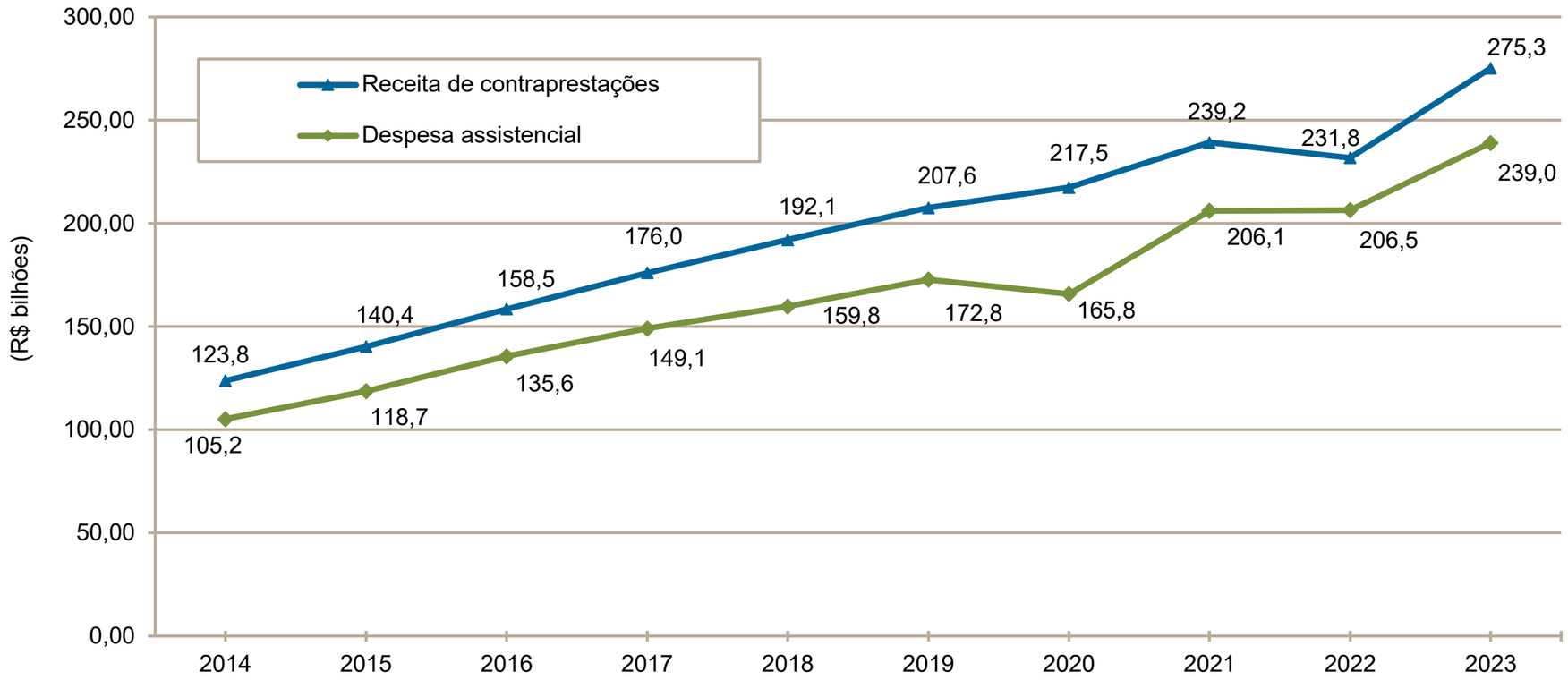
Fonte ANS
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2EyNGY3OGItNWZmYy00ZTJkLWI5YjAtMWU3OTFlZWNmNTYxIiwidCI6IjlkYmE0ODBjLTRmYTctNDJmNC1iYmEzLTBmYjEzNzVmYmU1ZiJ9

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

De 2021 para 2022 a receita com contraprestações encolheu 3,1% e as despesas assistenciais cresceram 0,2%

De 2022 para 2023 a receita com contraprestações cresceu 18,8% (reajustes de mensalidades) e as despesas assistenciais cresceram 15,8% (aumento significativo nos custos assistenciais e na frequencia)

Receitas de contraprestação e despesas operadoras médico-hospitalares



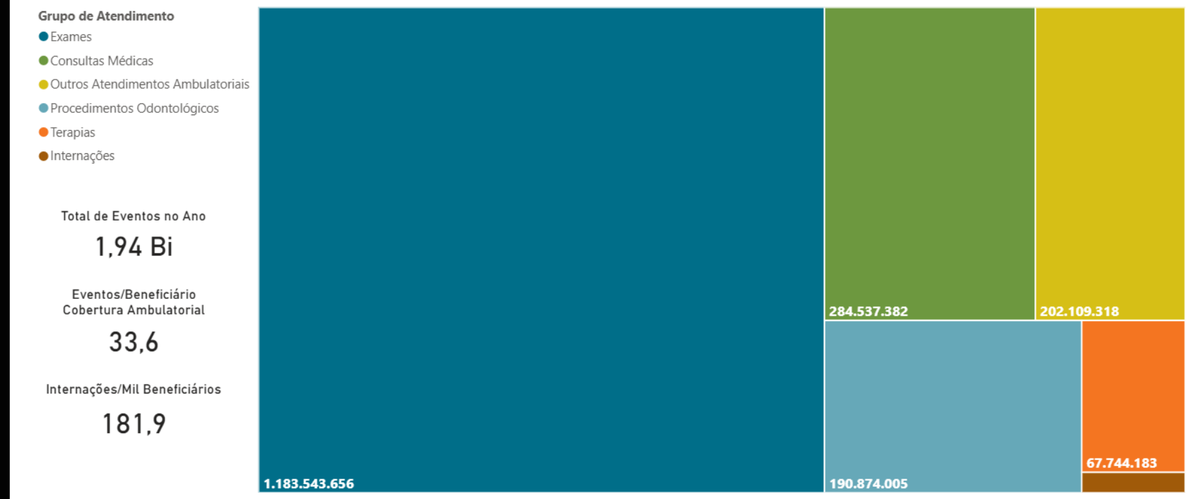
Fonte: ANS Dados Consolida
Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

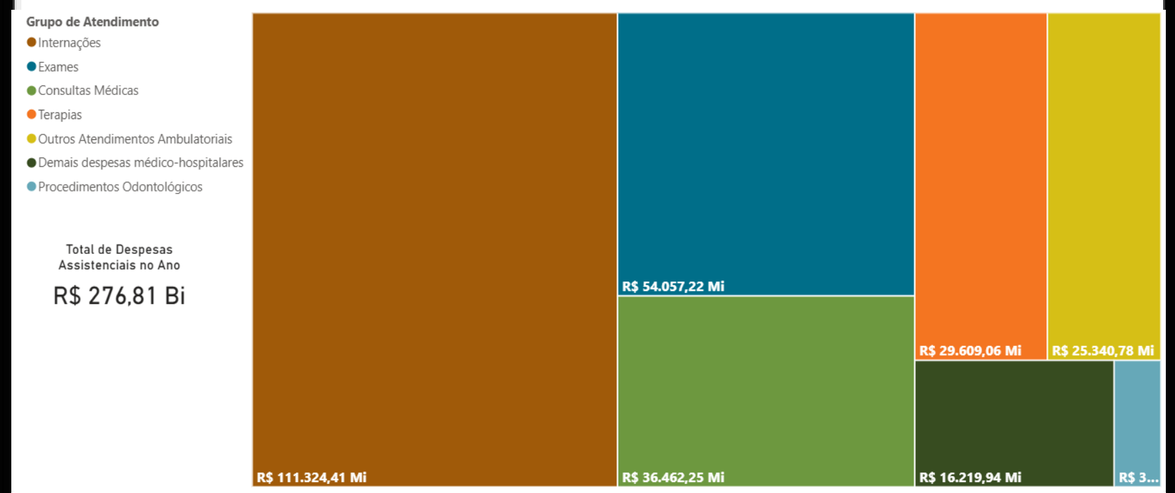
Internações representam 0,47% do total de eventos e correspondem a 40,2% da despesa assistencial

Exames representam 61% do total de eventos e correspondem a 19,5% das despesas assistenciais

Quantidade de Procedimentos por grupo de atendimento
(2024)



Despesas Assistenciais por grupo de atendimento
(2024)



Fonte: Mapa Assistencial da Saúde Suplementar
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGE2NTVjZjMtZWJjZS00YTA5LWJhMDUtMTU2MGJiMzBkNTE4IiwidCI6IjlkYmE0ODBjLTRmYTctNDJmNC1iYmEzLTBmYjEzNzVmYmU1ZiJ9

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Taxas de Sinistralidade das operadoras médico-hospitalares Complexas nos últimos anos...Sinais de retomada em 2025

Taxa de sinistralidade e receita média mensal operadoras médico-hospitalares, por tipo

Porte da operadora	2023		1º Trim/2023		1º Trim/2024	
	Taxa de sinistralidade (%)	Receita média mensal (R$)	Taxa de sinistralidade (%)	Receita média mensal (R$)	Taxa de sinistralidade (%)	Receita média mensal (R$)
Total	85,3	**1128,92**	**85,5%**	**275,99**	81,1	**301,41**
Operadoras médico-hospitalares	**86,8%**	**1804,79**	**87,1%**	**433,05**	**82,4%**	**484,03**
Pequeno porte (até 20.000 beneficiários)	84,5%	1718,10	82,4%	399,41	**82,0%**	**446,71**
Médio porte (20.000 a 100.000 beneficiários)	85,2%	1498,47	83,8%	372,65	**81,2%**	**395,28**
Grande porte (Acima de 100.000 beneficiários)	87,3%	1890,62	88,1%	450,57	**82,6%**	**510,00**
Operadoras exclusivamente odontológicas	**41,4%**	**44,51**	**36,1%**	**10,78**	**36,4%**	**10,60**
Pequeno porte (até 20.000 beneficiários)	47,2%	94,28	26,1%	3,12	**38,9%**	**0,73**
Médio porte (20.000 a 100.000 beneficiários)	56,6%	77,11	51,3%	19,86	**52,4%**	**19,72**
Grande porte (Acima de 100.000 beneficiários)	38,4%	39,98	33,5%	10,22	**33,6%**	**10,14**

Fonte: ANS Dados Consolidados da Saúde Suplementar Jun/2024

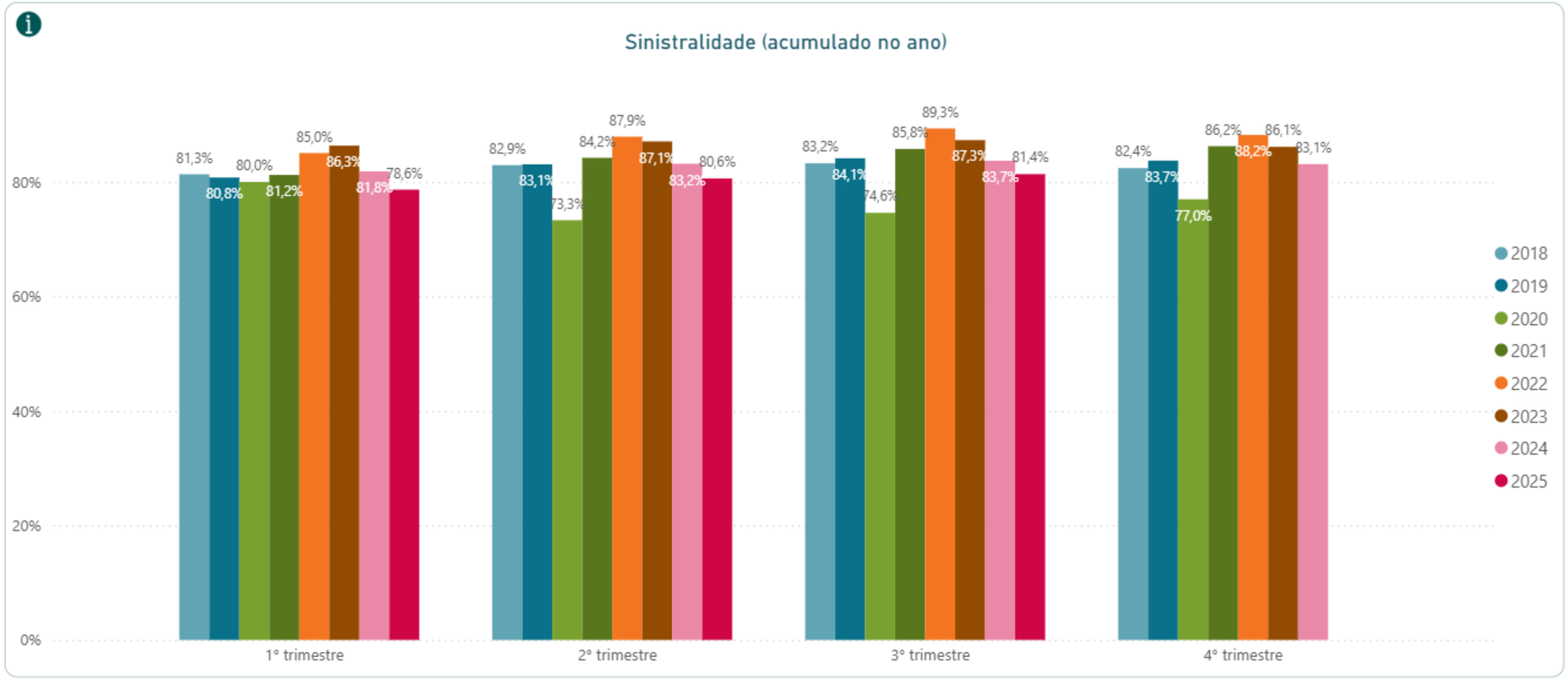
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Taxa de sinistralidade mais controlada operadoras médico-hospitalares em 2024

2024 – Seguradoras 87,2%, Autogestões 95% e Medicinas de Grupo 77,8%

Taxa de sinistralidade das operadoras médico-hospitalares

(2018-2025)



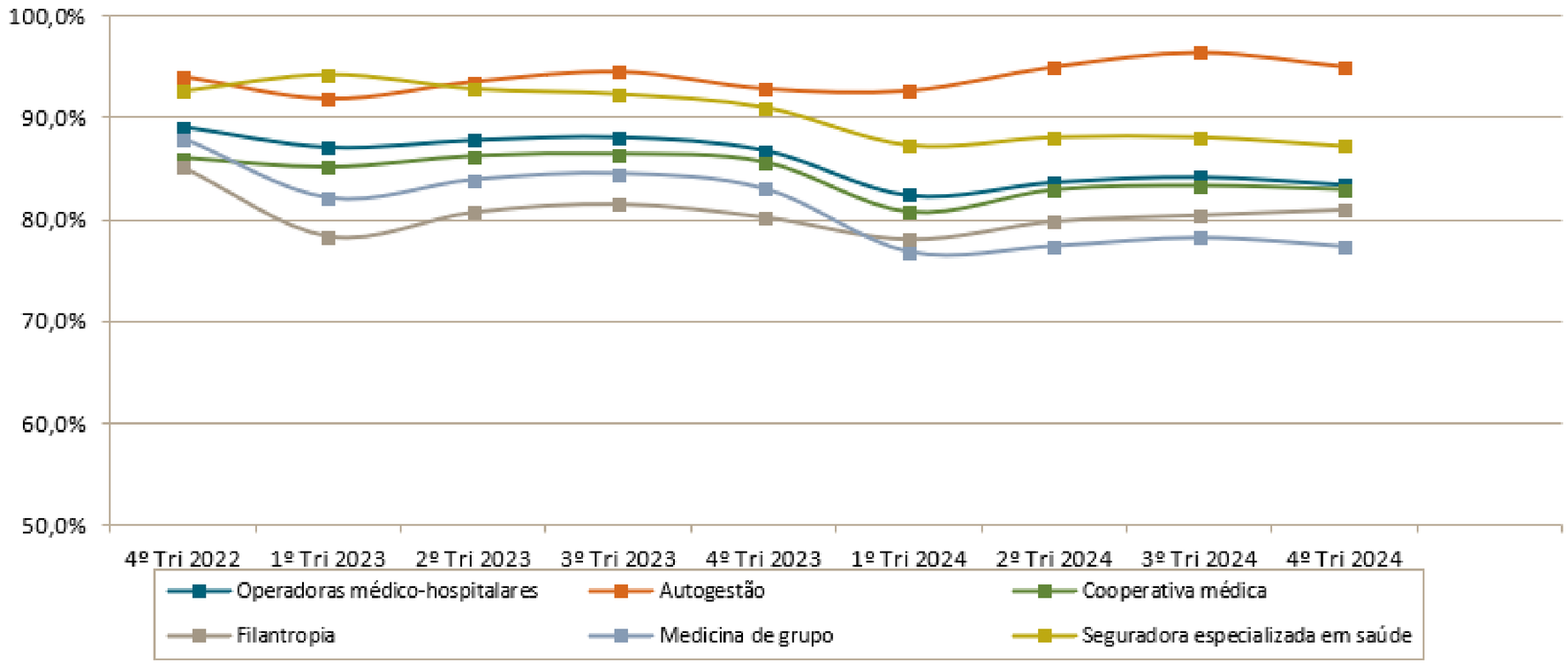
Fonte: ANS Painel Econômico Financeiro da Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Taxa de sinistralidade mais controlada operadoras médico-hospitalares em 2024

2024 – Seguradoras 87,2%, Autogestões 95% e Medicinas de Grupo 77,8%

Taxa de sinistralidade das operadoras médico-hospitalares, por modalidade
(2018-2025)



Fonte: ANS Painel Econômico Financeiro da Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Dentre os Prestadores de Serviços, cerca de 42% atendem a planos de saúde, sendo os hospitais especializados e os consultórios isolados os mais representativos

Estabelecimentos de saúde por atendimento a planos de saúde, por tipo
(Brasil – setembro 2023)

Tipo de estabelecimento	Total		Atendem a planos privados	
	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo
Total	**301.951**	**100%**	**126.314**	**41,8**
Clinica ou ambulatório especializado	67.904	100%	24.581	36,2
Consultório isolado	186.466	100%	83.557	44,8
Hospital especializado	1.010	100%	463	45,8
Hospital geral	5.374	100%	1.844	34,3
Policlínica	11.396	100%	4.449	39,0
Pronto socorro especializado	66	100%	22	33,3
Pronto socorro geral	279	100%	37	13,3
Unidade de serviço de apoio à diagnose e terapia	29.456	100%	11.361	38,6

Fonte: CNES/MS - 09/2023
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2023

Fonte: ANS
Caderno de Informações da Saúde Suplementar – Dez/24

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Os números apresentados demonstram a enorme relação de dependência entre o SUS, os planos de Saúde e os prestadores de serviços de saúde

Estabelecimentos de saúde por tipo de convênio, segundo tipo de atendimento
(Brasil – setembro 2023)

Tipo de atendimento	SUS	Particular	Plano de saúde público	Plano de saúde privado
Ambulatorial	91.990	267.859	17.765	171.129
Para internação	6.151	3.894	698	2.842
Serviços de apoio à diagnose e terapia	26.226	39.177	4.152	24.898
Urgência	11.277	4.110	628	2.768

Fonte: CNES/MS - 09/2023
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2023
Nota: A soma das parcelas não corresponde ao total de estabelecimentos uma vez que um mesmo estabelecimento pode atender a mais de uma forma de financiamento e constar em duas ou mais colunas.

Fonte: ANS
Caderno de Informações da Saúde Suplementar – Dez/24

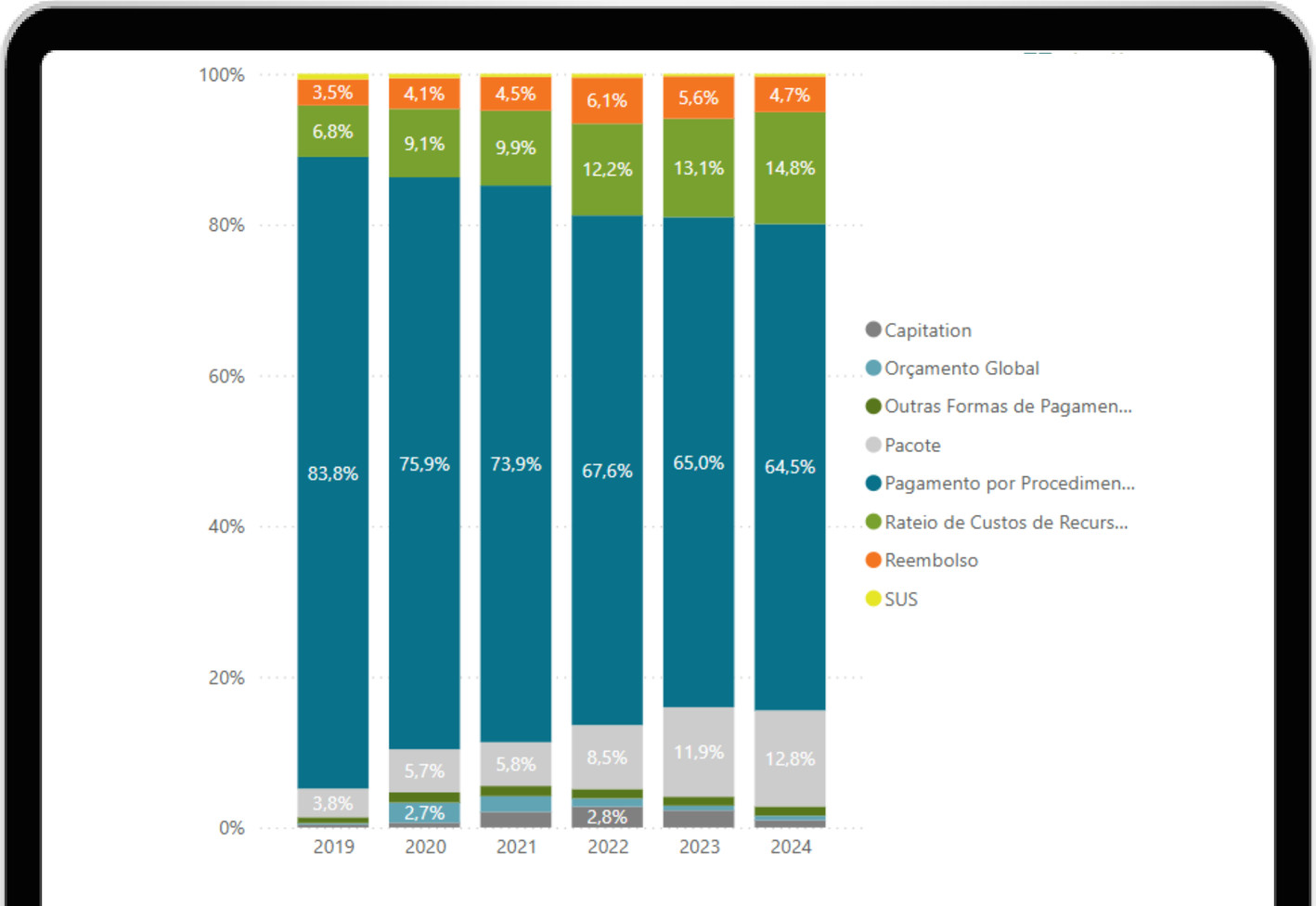
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Redução no Fee for Service e no Reembolso

Aumento na remuneração por pacotes e rateio de custos de recursos próprios

Percentual Eventos por Forma de Pagamento (acumulados no ano)

2019-2024



Fonte: ANS Painel Econômico Financeiro da Saúde Suplementar

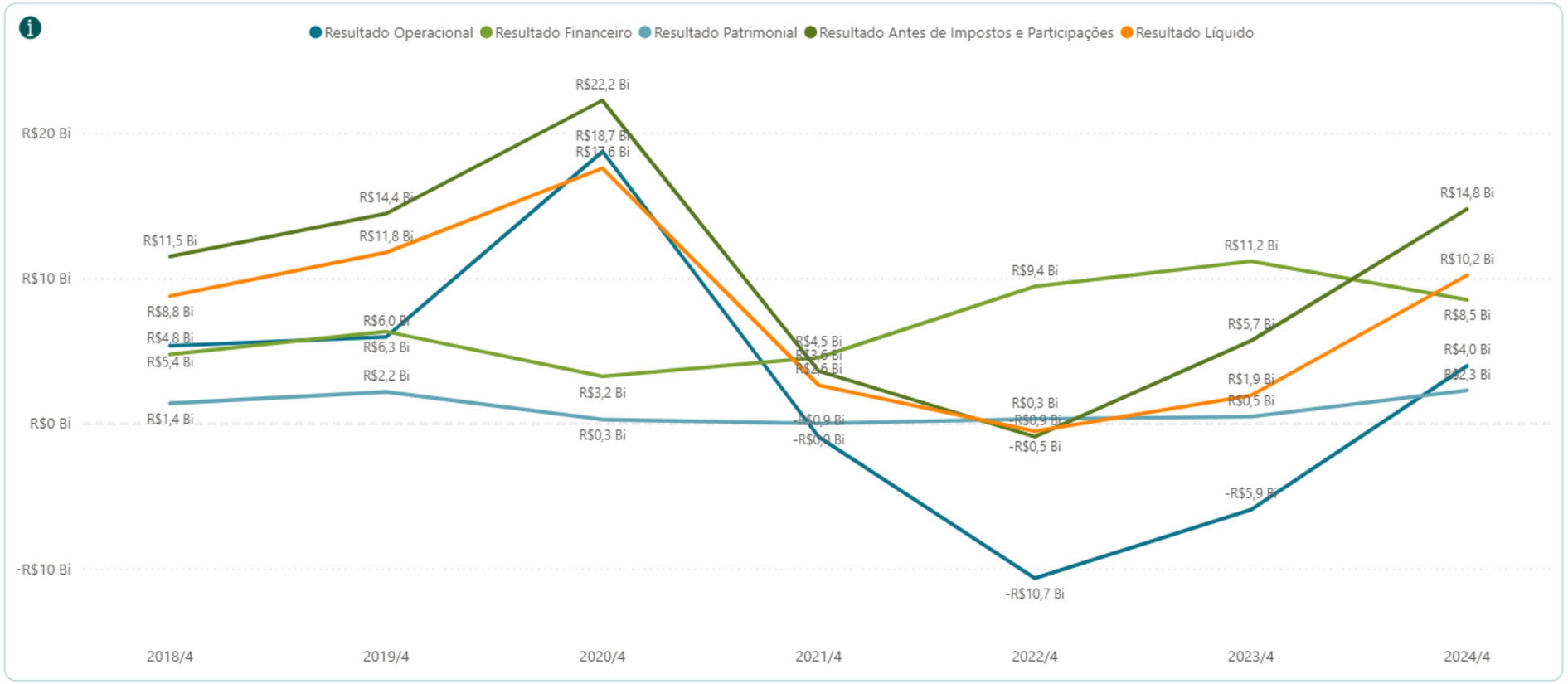
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

2021 a 2023 – resultados operacionais ruins

Como fechou 2024 – Resultados melhores e até o terceiro trimestre de 2025 segue adequado

Resultados - Acumulado no Ano

2018-2024



Fonte: ANS Painel Econômico Financeiro da Saúde Suplementar

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Questões para Discussão e/ou entendimento do papel do seu negócio no mercado de Saúde Suplementar?

1. Frente aos dados apresentados, quais os principais desafios para a Saúde Suplementar?
2. Quais ações podem ser tomadas pelas operadoras para endereçar estes desafios?
3. Como a sua instituição ou o seu negócio pode ser afetada pelas ações das operadoras para controle da sinistralidade?
4. Qual o público atendido na sua instituição e/ou negócio?
5. Como o público por vocês atendido pode ser afetado pelas ações das operadoras para controle de sinistralidade?
6. Quais os impactos da questão 5 para o seu negócio?
7. Quais operadoras têm maior representatividade, em quantidade de atendimentos, na sua instituição e/ou negócio?
8. Quais operadoras têm maior representatividade financeira na sua instituição e/ou negócio?
9. Quais operadoras trazem mais margem para a sua instituição e/ou negócio?
10. Como a concentração de operadoras pode afetar a sua instituição e/ou negócio?
11. Quais ações sua instituição poderia realizar para colaborar com o sistema, no controle da sinistralidade?
12. Quais ações os médicos poderiam realizar para colaborar com o sistema, no controle da sinistralidade?
13. Quais ações seus pacientes poderiam realizar para colaborar com o sistema, no controle da sinistralidade?
14. Quais outros agentes do sistema poderiam atuar em ações para o controle da sinistralidade?

O QUE VAMOS ESTUDAR

01
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

02
PRODUTO
Planos privados de assistência à saúde ou odontológicos

03
OPERADORAS DE SAÚDE

04
REGULAÇÃO ANS

05
INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Sinônimos:
Plano privado de assistência à saúde, ou Plano de saúde ou simplesmente Plano ou Produto

> prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor

LEI 9656/98

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Da origem aos dias atuais

Rev. Industrial Brasileira

1923
Lei Eloy Chaves
Caixas de Aposentadorias e Pensões)

1933
Institutos Aposentadorias e Pensões (IAPs)

ANOS 40
Caixas de Assistência
Ex: Cassi (BB)

ANOS 50
Empresas multinacionais e estatais
assistência médica de forma direta

ANOS 50
"Planos de saúde comerciais – clientelas "abertas"
Med de Grupo - ABC

1966
INPS
(fusão dos IAPs)

ANOS 70
SIMPAs
INAMPS

1988
Constituição Federal de 1988
Artigo 196 – Saúde Pública
Artigo 199 – Complementar - Privado

1999
Lei 9656/98
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde ou Odontológica

2000
Lei 9961
Criação da ANS

Hoje, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde é um dos maiores sistemas privados de saúde do mundo.

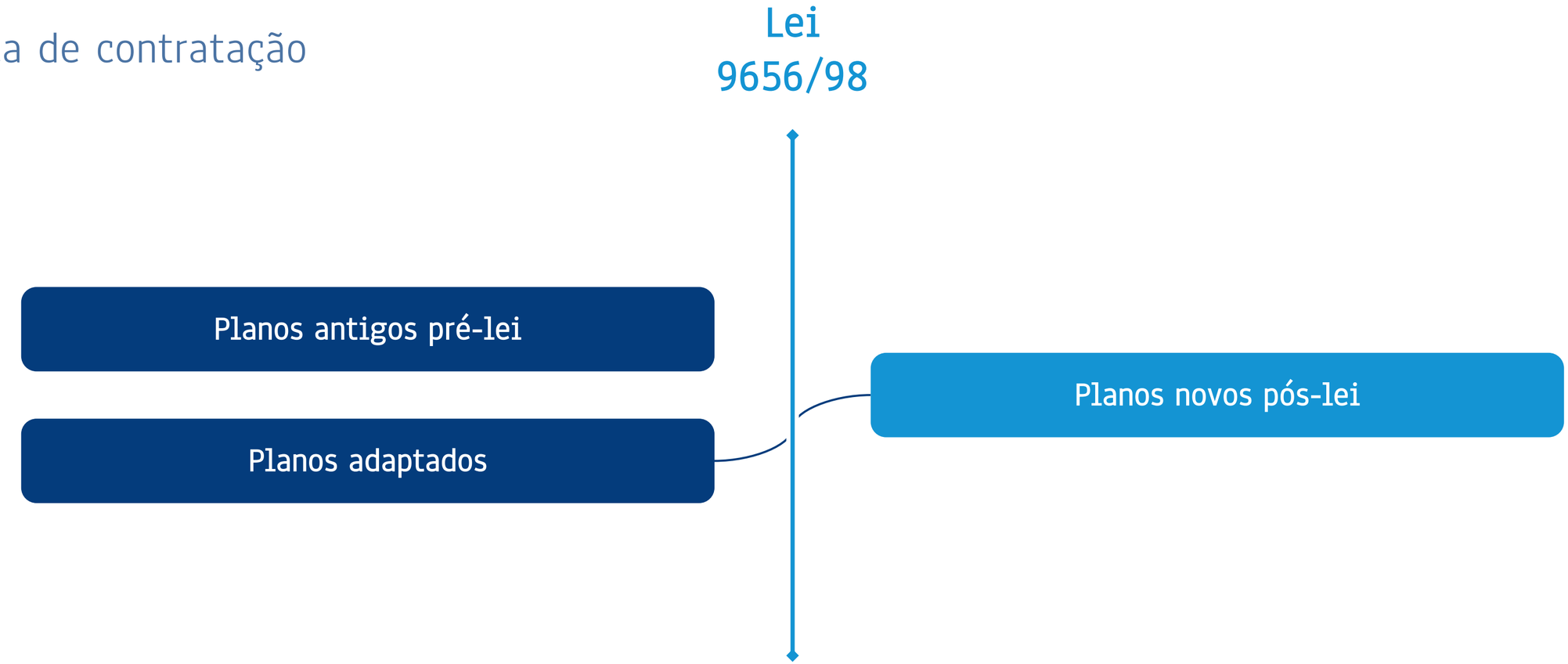
PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Os produtos podem ter uma série de características conforme:

- Época de contratação
- Tipo de contratação
- Tipo de atenção
- Segmentação Assistencial
- Abrangência Geográfica
- Padrão de Acomodação
- Formação de Preço
- Características quanto ao tipo de "cobertura"

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Época de contratação



PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Época de contratação

Lei
9656/98

Planos antigos pré-lei

Planos adaptados

Planos novos pós-lei

Coberturas seguem o que consta em contrato; cerca de 6% dos beneficiários dos beneficiários dos planos de assistência médica

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Época de contratação

Lei
9656/98

Planos antigos pré-lei

Planos adaptados

Planos novos pós-lei

Coberturas seguem o definido pela Lei 9656 com as atualizações conforme regulação

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Época de contratação

Lei
9656/98

Planos antigos pré-lei

Planos adaptados

Planos novos pós-lei

Planos comercializados antes da Lei 9656, mas que tiveram suas condições contratuais adequadas às regras da nova lei por meio de aditivo contratual

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Época de contratação

Lei
9656/98

Planos antigos pré-lei

Planos adaptados

Planos novos pós-lei

Coberturas seguem o definido pela Lei 9656 com as atualizações conforme regulação - 94% dos beneficiários dos planos de assistência médica

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Tipo de contratação

COLETIVO

- Coletivo Empresarial
- Coletivo por Adesão

INDIVIDUAL OU FAMILIAR

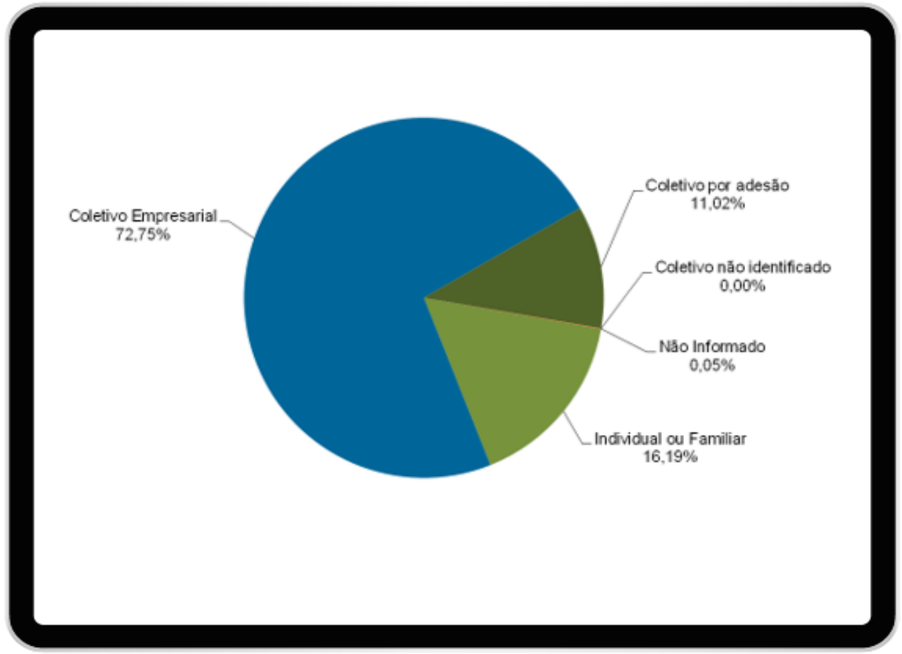
PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Tipo de contratação

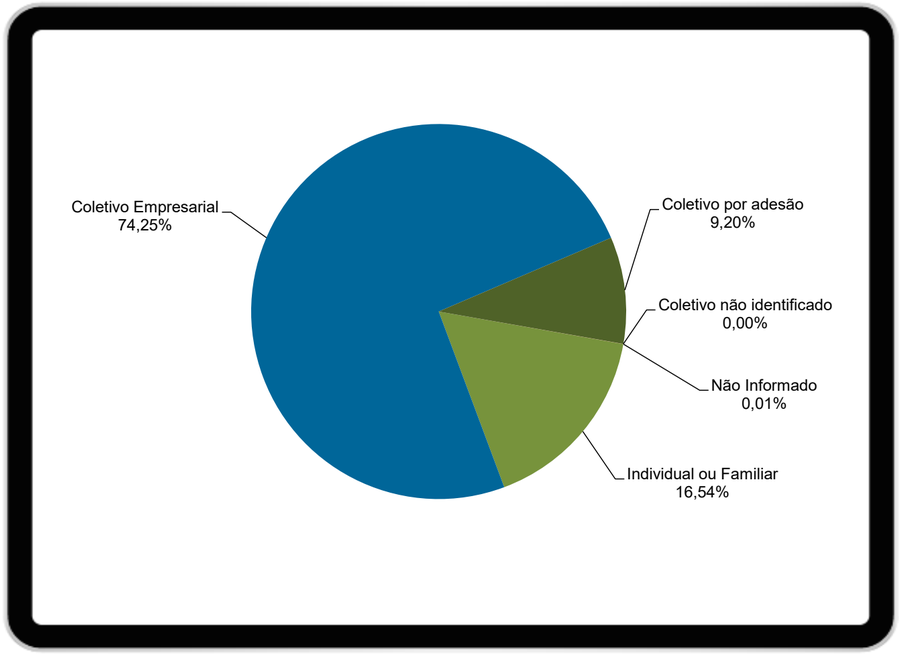
	Coletivo empresarial	Coletivo por adesão	Individual ou familiar
Quem contrata	Empresas –PJ - relação empregatícia ou estatutária	PJ – relação profissional, classista ou setorial Sindicatos ou Associações	Pessoa Física – individual com ou sem familiares
Reajustes	Livre negociação	Livre negociação	Limitado pela ANS
Exclusão do beneficiário	Perda de vínculo	Perda de vínculo	Inadimplência ou desistência do beneficiário
Rescisão contratual	Negociação e regida pelo contrato	Negociação e regida pelo contrato	Inadimplência ou desistência do beneficiário

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Distribuição conforme tipo de contratação
82% Coletivos



ASSISTÊNCIA MÉDICA



EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Tipo de atenção

MÉDICO-HOSPITALARES

MÉDICO-HOSPITALARES COM ODONTOLOGIA

EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Tipo de segmentação assistencial

HOSPITALAR

HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA

AMBULATORIAL

HOSPITALAR E AMBULATORIAL COM OBSTETRÍCIA

HOSPITALAR E AMBULATORIAL COM OBSTETRÍCIA EM ENFERMARIA

(plano referência)

ODONTOLÓGICO

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Ambulatorial

Consultas inclusive obstétricas e pré-natal	Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
Tratamentos ambulatoriais mesmo cirúrgicos, desde que não necessitem internação	Nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia, psicologia, obstetriz e enfermeiro obstétrico
Urgencia ou emergencia – **primeiras 12 horas**	Procedimentos ambulatoriais com ou sem anestesia local, sedação ou bloqueio
Remoção se caracterizada necessidade de internação	Quimioterapia ambulatorial e antineoplásicos orais, adjuvantes e para controle de efeitos colaterais
Radioterapia/diálise/hemodinâmica ambulatorial	
Cirurgia oftalmológicas (de acordo com a segmentação do rol)	

Cobertura somente para atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios

Não inclui internações – sem cobertura inclusive para:
Exames e procedimentos que possam vir a necessitar de internação, estrutura hospitalar por
Um período superior a 12 horas e ou serviços como uti

Fonte: RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021– ROL DE PROCEDIMENTOS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Hospitalar sem obstetrícia

Internações hospitalares	Atendimento de urgencia e emergencia
Tratamentos ambulatoriais para procedimentos especiais necessários a continuidade do tratamento Iniciado na internação – depende de análise da DUT	
Hemoterapia/radioterapia	Exames pré anestésicos e pré cirúrgicos
Hemodiálise/diálise peritoneal	Radioterapia, radiologia intervencionista, hemodinâmica (diagnóstica e cirúrgica)
Nutrição parenteral ou enteral	
Radiologia intervencionista	Quimioterapia ambulatorial, antineoplásicos orais, adjuvantes E para controle de efeitos adversos

Fonte: RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021– ROL DE PROCEDIMENTOS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Hospitalar com obstetrícia

Segmentação hospitalar sem obstetrícia

+

Pré parto

Parto

Pós parto imediato (10 dias após o parto
Salvo intercorrências)

Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, durante os primeiros trinta dias após o parto

Inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carências, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção

Cobertura para partos normais realizados por enfermeiro obstétrico ou obstetriz habilitados

Fonte: RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021- ROL DE PROCEDIMENTOS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Odontológico – não tem segmentação

Procedimentos odontológicos realizados em consultório e no rol

Sem cobertura para procedimentos internados,
Caso haja necessidade de internação há cobertura somente dos materiais e honorários odontológicos

Para cobertura de procedimentos odontológicos (buco maxilo por exemplo)
Há necessidade da contratação de plano de saúde – segmentação hospitalar ou referência

Fonte: RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021– ROL DE PROCEDIMENTOS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Abrangência geográfica

NACIONAL

ESTADUAL

GRUPO DE ESTADOS

MUNICIPAL

GRUPO DE MUNICÍPIOS
(2 ou mais, menos de 50% do estado)

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Padrão de acomodação

ENFERMARIA
(quarto coletivo)

APARTAMENTO
(acomodação individual)

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Características quanto ao tipo de "cobertura"

PREVISÃO OU NÃO DE REEMBOLSO

REDE DE PRESTADORES

COBERTURAS ADICIONAIS
(extra-rol)

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Formação de preço

PRÉ-ESTABELECIDO
(pré-pagamento)

PÓS-ESTABELECIDO
(pós-pagamento)

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Coberturas e serviços não cobertos

ANS define e atualiza periodicamente uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

Há variação conforme cada tipo de plano de saúde - ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico

O “Rol” é válido para os planos novos e para os antigos adaptados

Fazem parte do “Rol” as Diretrizes de Utilização (DUT) que são as diretrizes que regulamentam a cobertura dos procedimentos/eventos em saúde a elas relacionadas

Nos planos regulamentados pela Lei nº 9.656, de 1998 (planos novos) é obrigatória a cobertura às próteses, órteses e seus acessórios que necessitam de cirurgia para serem colocados ou retirados (materiais implantáveis). É permitida a exclusão de cobertura ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), tais como óculos, coletes ortopédicos, próteses de substituição de membros, por exemplo.

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Exclusões permitidas

- tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- procedimentos clínicos ou cirúrgicos com finalidade estética
- fornecimento de medicamentos para uso domiciliar (com exceções)
- tratamentos ilícitos ou antiéticos
- estabelecimentos para acolhimento de idosos
- internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

Anexo 1. Lista de procedimentos e vinculação de coberturas conforme características do produto

ANEXO I

(RN 465/2021
e suas alterações)

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

(RN 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021
e suas alterações:)

RN nº 473/2021, vigente a partir de 08/11/2021
RN nº 478/2022, vigente a partir de 20/01/2022
RN nº 480/2022, vigente a partir de 14/02/2022
RN nº 536/2022, vigente a partir de 06/05/2022
RN nº 538/2022, vigente a partir de 22/10/2022
RN nº 541/2022, vigente a partir de 01/08/2022
RN nº 542/2022, vigente a partir de 01/09/2022
RN nº 544/2022, vigente a partir de 21/09/2022
RN nº 546/2022, vigente a partir de 03/10/2022

PROCEDIMENTO	RN (alteração)	VIGÊNCIA	OD	AMB	HCO	HSO	REF	PAC	DUT	SUBGRUPO	GRUPO	CAPÍTULO
REABILITAÇÃO PERINEAL/VESICO-URETRAL COM OU SEM BIOFEEDBACK				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUACAÇÃO E REABILITAÇÃO DE QUEIMADOS PARA PREVENÇÃO DE SEQUELAS				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DO SISTEMA LINFÁTICO E/OU VASCULAR PERIFÉRICO				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DO SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO POR DISTÚRBIOS CONGÊNITOS OU REUMÁTICOS				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO TRAUMATO-ORTOPÉDICA (EXCLUI TÉCNICAS CINESIOTERÁPICAS ESPECÍFICAS)				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO DE DISTÚRBIOS CRÂNIO-FACIAIS				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
REEDUCAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS PÉLVICOS				AMB	HCO	HSO	REF			REABILITAÇÃO	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
ACTINOTERAPIA				AMB	HCO	HSO	REF			TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)			OD						79	TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
APLICAÇÃO DE HIPOSSENSIBILIZANTE				AMB	HCO	HSO	REF			TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
APLICAÇÃO DE SELANTE (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)			OD						80	TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR			OD							TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
APLICAÇÃO TÓPICA DE VERNIZ FLUORETADO			OD							TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
BETATERAPIA				AMB	HCO	HSO	REF	PAC		TERAPÊUTICA	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

Legenda:
OD: Seg. Odontológica
AMB: Seg. Ambulatorial

HCO: Seg. Hospitalar Com Obstetrícia
HSO: Seg. Hospitalar Sem Obstetrícia
REF: Plano Referência

PAC: Procedimento de Alta Complexidade
DUT: Diretriz de Utilização

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

Demais anexos

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

Anexo II - DUTs

ROL DE PROCEDIMENTOS
E EVENTOS EM SAÚDE

ANEXO II

DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR

(RN 465/2021
e suas alterações)

c. História de mãe ter apresentado, durante a gestação do paciente, síndrome HELLP (hemólise, enzimas hepáticas aumentadas e baixa contagem de plaquetas) ou Fígado Gorduroso Agudo da Gravidez.

Método de análise espectrometria de massas em tandem qualitativo e quantitativo.

Referência Bibliográfica: Tandem Mass Spectrometry in Clinical Diagnosis in Nenad Blau; et al. Physician's guide to the laboratory diagnosis of metabolic diseases. Berlin: Springer, 2003, 2nd Ed. ISBN 3-540-42542-X

3. ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA

1. Cobertura obrigatória quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios (realização apenas em aparelhos multislice com 64 colunas de detectores ou mais):

a. avaliação inicial de pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste de 10 a 70% calculada segundo os critérios de Diamond Forrester revisado1, como uma opção aos outros métodos diagnósticos de doença arterial coronariana, conforme tabela a seguir:

Probabilidade pré-teste em pacientes com dor torácica (%)						
Idade	Angina Típica		Angina Atípica		Dor não anginosa	
	Homem	Mulher	Homem	Mulher	Homem	Mulher
30-39	59,1	22,5	28,9	9,6	17,7	5,3
40-49	68,9	36,7	38,4	14	24,8	8
50-59	77,3	47,1	48,9	20	33,6	11,7
60-69	83,9	57,7	59,4	27,7	43,7	16,9
70-79	88,9	67,7	69,2	37	54,4	23,8
>80	92,5	76,3	77,5	47,4	64,6	32,3

(adaptado de T.S.S. Genders ET AL, 2011)

b. dor torácica aguda, em pacientes com TIMI RISK 1 e 2, com sintomas compatíveis com síndrome coronariana aguda ou equivalente anginoso e sem alterações isquêmicas ao ECG e marcadores de necrose miocárdica;

c. para descartar doença coronariana isquêmica, em pacientes com diagnóstico estabelecido de insuficiência cardíaca (IC) recente, onde permaneça dúvida

sobre a etiologia da IC mesmo após a realização de outros exames complementares;

d. em pacientes com quadro clínico e exames complementares conflitantes, quando permanece dúvida diagnóstica mesmo após a realização de exames funcionais para avaliação de isquemia;

e. pacientes com suspeita de coronárias anômalas.

Referências Bibliográficas:

1. Genders TS, Steyerberg EW, Alkadhi H, Leschka S, Desbiolles L, Nieman K, Galema TW, Meijboom WB, Mollet NR, de Feyter PJ, Cademartiri F, Maffei E, Dewey M, Zimmermann E, Laule M, Pugliese F, Barbagallo R, Sinitsyn V, Bogaert J, Goetschalckx K, Schoepf UJ, Rowe GW, Schuijf JD, Bax JJ, de Graaf FR, Knuuti J, Kajander S, van Mieghem CA, Meijs MF, Cramer MJ, Gopalan D, Feuchtner G, Friedrich G, Krestin GP, Hunink MG. A clinical prediction rule for the diagnosis of coronary artery disease: validation, updating, and extension. Eur Heart J. 2011
2. Jensen JM, Voss M, Hansen VB, Andersen LK, Johansen PB, Munkholm H, Nørgaard BL. Risk stratification of patients suspected of coronary artery disease: comparison of five different models. Atherosclerosis. 2012 Feb;220(2):557-62.
3. Mark DB, Berman DS, Budoff MJ, et al. ACCF/ACR/AHA/NASCI/SAIP/SCAI/SCCT 2010 expert consensus document on coronary computed tomographic angiography: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents. Circulation 2010;121:2509-43.
4. Taylor AJ, Cerqueira M, Hodgson JM, et al. ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology, the North American Society for Cardiovascular Imaging, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. Circulation 2010;122:e525-55.
5. Min JK, Shaw LJ, Berman DS. The present state of coronary computed tomography angiography a process in evolution. J Am Coll Cardiol;55:957-65.

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

Anexo III – Diretrizes Clínicas

ROL DE PROCEDIMENTOS
E EVENTOS EM SAÚDE

ANEXO III

DIRETRIZES CLÍNICAS PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE

(RN 465/2021
e suas alterações)

2 CONSULTA – PUERICULTURA

Quando o procedimento consulta, corresponder a uma consulta de puericultura deverá atender os seguintes critérios:

a. atendimento ambulatorial sequencial e limitado, conforme calendário abaixo;

Lactente 0-2 anos	Pré-escola 2-4 anos	Escolar 5-10 anos	Adolescente 11-19 anos
1ª semana	24 meses	5 anos	11 anos
1 mês	30 meses	6 anos	12 anos
2 meses	36 meses	7 anos	13 anos
3 meses	42 meses	8 anos	14 anos
4 meses	48 meses	9 anos	15 anos
5 meses		10 anos	16 anos
6 meses			17 anos
9 meses			18 anos
12 meses			19 anos
15 meses			
18 meses			

b. incluir as ações a serem realizadas nos atendimentos agendados em conformidade com os itens abaixo descritos:

4

- avaliação do estado nutricional da criança pelo indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde;
- avaliação da história alimentar;
- avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde;
- estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde;
- avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor;
- avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola;
- avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde;
- exame da capacidade visual;
- avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde;
- avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança;
- avaliação do desenvolvimento da sexualidade;
- avaliação quantitativa e qualitativa do sono;
- avaliação da função auditiva;
- avaliação da saúde bucal.

Referência: CBHPM, 2012.

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

Anexo IV – Protocolos de Utilização

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

ANEXO IV

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO – PROUT

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COLETORES E ADJUVANTES PARA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA, SONDA VESICAL DE DEMORA E COLETOR DE URINA

(RN 465/2021
e suas alterações)

1. Para fins desta Resolução Normativa serão utilizadas as seguintes definições:

a) Os termos ostomias e estomias serão utilizados para o mesmo fim.

b) Pessoa com estomia é aquela que em decorrência de um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização do sistema (digestório e/ou urinário), possui uma abertura artificial entre os órgãos internos com o meio externo.

c) Estomia é um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização do sistema digestório e/ou urinário, criando um orifício externo que se chama estoma.

d) Estomias intestinais (colonostomia e ileostomia) são intervenções cirúrgicas realizadas, tanto no cólon (intestino grosso) como no intestino delgado e consiste na exteriorização de um segmento intestinal, através da parede abdominal, criando assim uma abertura artificial para a saída do conteúdo fecal.

e) Estomias urinárias ou derivações urinárias são uma abertura abdominal para a criação de um trajeto de drenagem da urina. São realizadas por diversos métodos cirúrgicos, com objetivo de preservar a função renal.

f) Os equipamentos coletores para estomas intestinais e urinários referem-se a bolsas de sistemas únicos ou compostos, descartáveis, fixadas à pele, ao redor do estoma, e que visam a coletar os efluentes, fezes ou urina, sendo de fundamental importância para o processo de reabilitação biopsicossocial da pessoa estomizada. Os equipamentos coletores para estomas intestinais e urinários são constituídos basicamente de bolsa coletora, para recolhimento do efluente, e de adesivos, para a fixação da bolsa à pele periestoma.

g) Os equipamentos adjuvantes de proteção e segurança para estomas intestinais e urinários referem-se a barreiras protetoras de pele necessários para pessoas com estomias.

Referência: Associação Brasileira Estomaterapia. Estomia, feridas e incontinências - SOBEST. Definições operacionais das características dos equipamentos e adjuvantes para estomias. Rev Estima 4(4): 40-3, 2006.

Art. 10.

.....

§ 4º. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

.....

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, **constitui a referência básica** para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de **tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo** assistente que **não estejam previstos** no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura **deverá ser autorizada** pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista **comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas** e plano terapêutico; ou
II - existam **recomendações** pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde **(Conitec)**, ou exista recomendação de, **no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)**

FGV

PRODUTO PLANO DE SAÚDE

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - **Lei 14.454/22** de 21 de setembro de 2022

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer **critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol** de procedimentos e eventos em saúde suplementar

STF – ADI 7.265 (SET/2025)

ANS é que organiza e fiscaliza os planos de saúde e tem a função de montar a lista de procedimentos que os planos devem cobrir, baseada em critérios técnicos (eficácia, segurança e garantindo o direito dos beneficiários e a sustentabilidade dos planos de saúde)

Lei 14.454/22 – requisitos amplos demais para conceder tratamentos fora do rol

Os planos de saúde só devem ser obrigados a cobrir tratamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais, quando cumpridos **todos estes requisitos**:
(i) prescrição pelo médico ou dentista responsável;
(ii) inexistência de decisão da ANS negando o tratamento ou de análise pendente pela agência;
(iii) ausência de outro tratamento eficaz e adequado (alternativa terapêutica) já previsto na lista;
(iv) comprovação científica robusta de que o tratamento funciona e é seguro à luz da medicina baseada em evidências; e
(v) registro do tratamento na Anvisa

Parâmetros buscam proteger os pacientes contra terapias que não funcionam e valorizar o trabalho técnico da ANS, sem comprometer o equilíbrio financeiro dos planos de saúde.

ADI7265_rolANS_vRev_Final.pdf

STF – ADI 7.265 (SET/2025)

A Justiça não pode se tornar o principal caminho para obter tratamentos fora da lista da ANS. Se uma **pessoa** entrar na Justiça pedindo um tratamento fora do rol, **deve comprovar que fez o pedido ao plano e que o plano negou ou demorou para responder**. O juiz só poderá autorizar a cobertura se **todos os cinco critérios estiverem presentes**. Para tomar sua decisão, o juiz deve **consultar órgãos técnicos** e não pode substituir a função e a análise técnica da ANS. Essas regras ajustam o papel do Poder Judiciário na definição de coberturas de, **desestimulando a judicialização excessiva e reforçando a importância das evidências técnicas e científicas**. Isso ajuda a **manter o sistema organizado, valoriza o trabalho técnico da ANS e garante mais segurança tanto para os pacientes quanto para as operadoras**.

STF – ADI 7.265 (SET/2025)

A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando abaixo:

Deverá obrigatoriamente:
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, **não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte**; e
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, **oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória**".

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

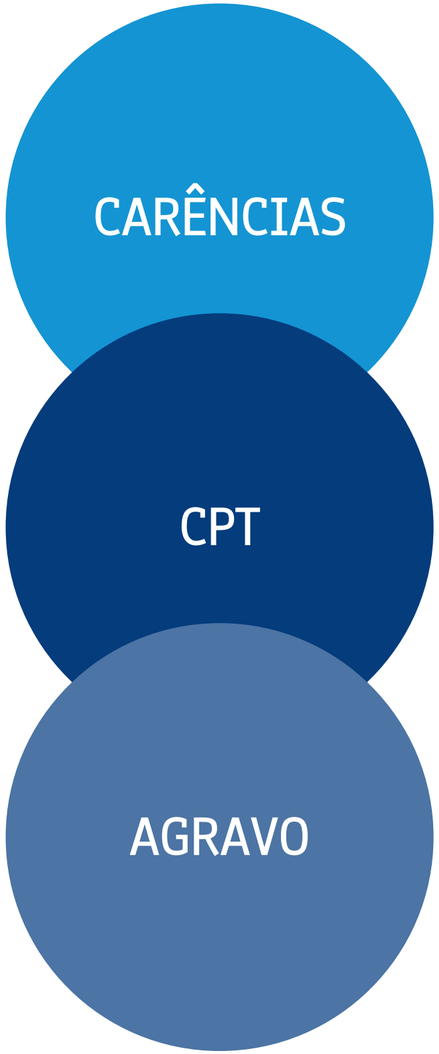
E a partir de quando estas coberturas são válidas?

Há elementos permitidos e utilizados para a regulação e o controle de custos.

Eles existem para **diminuir riscos** da contratação de planos de saúde por parte de **beneficiários** que desejam e/ou necessitam **uso imediato** do plano de saúde

Diminuir o risco moral e a assimetria de informação

Relembrando: pela própria definição do produto, uma vez contratado o uso é ilimitado em frequência e despesa assistencial (exceto pelas limitações claras das normas da agência reguladora)



PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Carências

CPT

Agravo

> dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 557
14 DE DEZEMBRO DE 2022

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Carências

CPT

Agravo

Período corrido e ininterrupto, determinado em contrato, contado a partir da data de início da vigência do contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual o contratante paga as contraprestações pecuniárias, mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas previstas no contrato.

Seus prazos máximos* são:

a) 24 horas para atendimento de urgência e emergência;
b) 300 dias para parto a termo
c) 180 dias para os outros eventos – consultas, exames, internações e cirurgias

*a operadora pode estabelecer prazos menores (nunca maiores) para as carências

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Carências

Cobertura assistencial que admite, por período ininterrupto de até 24 meses a partir da contratação ou adesão ao plano, a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes (DLP) declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde.

CPT

Agravo

Declaração de saúde ou DPS e o formulário que acompanha o contrato do plano onde o beneficiário (ou representante legal) é obrigado a informar à operadora quando solicitado, as doenças ou lesões preexistentes que saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação do plano privado de assistência à saúde.

*a omissão da informação é considerada fraude e poderá acarretar a suspensão ou rescisão do contrato

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Carências

CPT

Agravo

Acréscimo temporário no valor da contraprestação pecuniária do plano privado de assistência à saúde, oferecido ao consumidor que se declare portador de doenças ou lesões preexistentes, para que este tenha direito integral à cobertura contratada, como alternativa à adoção de cláusula de cobertura parcial temporária.

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Mecanismos de regulação, financeiros

Franquia

Coparticipação

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Mecanismos de regulação, financeiros

Franquia

Estabelecimento de valor até o qual a operadora não tem responsabilidade de reembolso, nem de pagamento da assistência à rede credenciada ou referenciada.

*a franquia é paga pelo beneficiário diretamente ao prestador da rede credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço. Mais utilizada nos planos odontológicos que nos de assistência médica.

Coparticipação

Participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário diretamente à operadora, em caso de plano individual e familiar, ou à pessoa jurídica contratante, em caso de plano coletivo, após a realização de procedimento.

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Mecanismos de regulação, financeiros

Franquia

Estabelecimento de valor até o qual a operadora não tem responsabilidade de reembolso, nem de pagamento da assistência à rede credenciada ou referenciada.

*a franquia é paga pelo beneficiário diretamente ao prestador da rede credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço. Mais utilizada nos planos odontológicos que nos de assistência médica.

Coparticipação

Participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário diretamente à operadora, em caso de plano individual e familiar, ou à pessoa jurídica contratante, em caso de plano coletivo, após a realização de procedimento.

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Formação do preço

Pré-estabelecido ; Pré-pagamento

O contratante transfere a responsabilidade do pagamento da assistência para as operadoras, mediante pagamento mensal fixo de um valor previamente acordado. O valor (preço) é fixo por um ano e o risco é da operadora.

ex: Planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais. Para os contratos com pessoas jurídicas, há cláusulas de reajustes por sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares (VCMH)

Pós-estabelecido ; Pós-pagamento

O contratante absorve integralmente os custos do plano, podendo administrá-lo diretamente ou por uma operadora (a rede utilizada é a contratada pela operadora), através do pagamento de uma taxa de administração. O valor a ser pago varia mensalmente conforme as despesas assistenciais e o risco é do contratante que pagará integralmente pela assistência.

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Formação do preço

Pré-estabelecido ; Pré-pagamento

O contratante transfere a responsabilidade do pagamento da assistência para as operadoras, mediante pagamento mensal fixo de um valor previamente acordado. O valor (preço) é fixo por um ano e o risco é da operadora.

ex: Planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais. Para os contratos com pessoas jurídicas, há cláusulas de reajustes por sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares (VCMH)

Pós-estabelecido ; Pós-pagamento

O contratante absorve integralmente os custos do plano, podendo administrá-lo diretamente ou por uma operadora (a rede utilizada é a contratada pela operadora), através do pagamento de uma taxa de administração. O valor a ser pago varia mensalmente conforme as despesas assistenciais e o risco é do contratante que pagará integralmente pela assistência.

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Preços do produtos

Definidas as características do produto é realizado o **cálculo atuarial** para a formação de preço do produto a ser colocado no mercado.

Elabora-se a **Nota Técnica do Produto** assinada por atuário e submete-se à ANS para o Registro do Produto. Como o produto de saúde (plano de saúde) sofre forte influência da faixa etária, existem regras estabelecidas pela ANS sobre as variações de preços entre as faixas etárias.

NO CÁLCULO, SÃO CONSIDERADAS:

- Características dos produtos (já estudadas), incluindo o risco (planos pré-pagamento)
- Despesas administrativas
- Despesas de comercialização (incluindo corretagem)
- Margem de lucro

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Preços do produtos

I	0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II	19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III	24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV	29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V	34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI	39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII	44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII	49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;
IX	54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;
X	59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Última faixa etária não pode ultrapassar 6x o valor da primeira faixa (conceito da solidariedade intergeracional – mais jovens subsidiam os mais velhos)

A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima, evitando a concentração de pesados reajustes nas últimas faixas etárias

Variação de preços para as faixas etárias imediatamente superiores não podem apresentar percentuais negativos

PRODUTO
PLANO DE SAÚDE

Reajustes

Faixa etária

Quando um indivíduo muda de faixa etária, passa a pagar o valor correspondente à nova faixa etária

Anual

Aplicado anualmente no mês de aniversário do contrato

Individuais / familiares novos

Reajuste definido anualmente pela ANS conforme metodologia própria Agência

Individuais / familiares antigos

Reajustes seguem as regras definidas em contrato

Coletivos

Livre negociação entre operadoras e contratantes

- Sua regra é definida em contrato
- Variações nos custos administrativos, comerciais e financeiros da operadora
- Sinistralidade no período ("reajuste por sinistralidade")
- Contratos: índice máximo de sinistralidade que a operadora suporta (não incide este reajuste). Caso a sinistralidade seja maior (ocorre prestação de contas) apura-se a necessidade de reajuste para suprir a distorção

O QUE VAMOS ESTUDAR

01
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

02
PRODUTO
Planos privados de assistência à saúde ou odontológicos

03
OPERADORAS DE SAÚDE

04
REGULAÇÃO ANS

05
INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

- MEDICINA DE GRUPO
- ODONTOLOGIA DE GRUPO
- COOPERATIVA MÉDICA
- COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
- SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE
- AUTOGESTÃO
- FILANTROPIA
- ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

MEDICINA DE GRUPO

Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui em sociedade que opera planos privados de assistência à saúde, excetuando-se as classificadas nas modalidades: administradora, cooperativa médica, autogestão, filantropia e seguradora especializada em saúde.

Obs: Pode ou não ter fins lucrativos e pode ou não ter rede própria.

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

ODONTOLOGIA DE GRUPO

Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui em sociedade que opera exclusivamente planos privados de assistência à saúde exclusivamente odontológicos, excetuando-se as classificadas na modalidade cooperativa odontológica.

Obs. Pode ou não ter fins lucrativos e pode ou não ter rede própria.

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

COOPERATIVA MÉDICA

Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui como associação sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por médicos e que opera planos de assistência à saúde.

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui como associação sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por odontólogos e que opera planos de assistência à saúde exclusivamente odontológicos.

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Sociedade seguradora que opera seguro saúde e possui objeto social exclusivo para a atuação no setor de Saúde Suplementar, nos termos da Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001. Para fins da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano privado de assistência à saúde.

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

AUTOGESTÃO

Modalidade na qual é classificada uma operadora que opera planos privados de assistência à saúde a um grupo fechado de pessoas, que obrigatoriamente devam pertencer à mesma classe profissional ou terem vínculo com a empresa instituidora e/ou patrocinadora e/ou mantenedora da operadora de planos de assistência à saúde. A autogestão pode ser classificada como: autogestão por recursos humanos (RH), autogestão com mantenedor ou autogestão sem mantenedor.

Obs. Existe uma RN específica para regras das autogestões – RN 137

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

FILANTROPIA

Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui como pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de utilidade pública e detentora de certificado de entidade beneficente de assistência social, emitida pelos órgãos competentes.

OPERADORAS DE SAÚDE

Modalidades

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Pessoa jurídica que propõe a contratação de plano privado coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados coletivos de assistência à saúde, e desenvolve atividades previstas em regulamentação específica (RN Nº 515, DE 29/04/2022) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Administra planos de saúde, sem assumir o risco decorrente da operação desses planos, e não possui rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos.

Obs. A RN 515/22 revogou a RN 196, de 14/07/2009

OPERADORAS DE SAÚDE

O que é necessário para uma operadora funcionar?

1

Autorização de Funcionamento pela ANS

Registro da Operadora

Registro de Produtos (cada produto precisa de um número de registro na ANS)

2

Envio recorrente de informações para a ANS

3

Estar adequada à fiscalização (normas específicas)

mas, atenção!

1. Registro da Operadora por si só não a autoriza a iniciar suas atividades de comercialização ou disponibilização de produtos, mas é uma premissa para o ingresso de uma solicitação de Registro de Produto. A Autorização de Funcionamento da operadora será concedida mediante a concessão de ao menos um Registro de Produto.

2. Em caso de encerramento de atividades pela operadora a aprovação prévia pela a ANS é requerida, bem como a concomitante transferência dos beneficiários para outra operadora. Atos societários de operadoras como alterações ou transferências de controle societário, cisões, fusões, aquisições, entre outros, também necessitam de aprovação da ANS.

OPERADORAS DE SAÚDE

Envio de informações para ANS

- BENEFICIÁRIOS
- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
- ALTERAÇÕES DE PRODUTOS
- REAJUSTES DE PREÇOS
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- COMPROVAR POSSUIR GARANTIAS DE SOLVÊNCIA

Caso sejam encontradas anormalidades administrativas graves com risco patente à continuidade e à qualidade dos atendimentos assistenciais aos beneficiários, e/ou anormalidades econômico-financeiras graves, a ANS poderá notificar a operadora para apresentar um plano de contingenciamento e resolução dos problemas encontrados.

OPERADORAS DE SAÚDE

Registro de produtos

NTRP (Nota Técnica de Registro de Produtos)
Documento elaborado por atuário, legalmente habilitado, no qual são descritas as formulações e observações necessárias ao cálculo da formação dos preços dos planos e produtos de assistência suplementar à saúde

Pagamento da Taxa de Registro de Produtos

Fornecer as informações sobre o produto a ser comercializado

OPERADORAS DE SAÚDE

Ações fiscalizatórias da ANS

- Fase Pré-Processual
  (NIPs ou Procedimento Administrativo Preparatório)
- Processo Administrativo para apuração da infração e aplicação da sanção
  - Auto de infração
  - Representação
- Ciclo de Fiscalização
- Intervenção Fiscalizatória
- Outras modalidades de fiscalização

OPERADORAS DE SAÚDE

Notificação de Intermediação Preliminar - NIP

Instrumento que visa à solução de conflitos entre beneficiários e Operadoras.

Ela é classificada em:

A notificação que terá como referência toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial

NIP ASSISTENCIAL

A notificação que terá como referência outros temas que não a cobertura assistencial, desde que o beneficiário seja diretamente afetado pela conduta e a situação seja passível de intermediação.

NIP NÃO ASSISTENCIAL

OPERADORAS DE SAÚDE

REGRAS QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA REGISTRO E FUNCIONAMENTO

- Recursos minimos para constituir a empresa
- Provisões técnicas para garantia de funcionamento
- Ativos garantidores para garantia de pagamento
- Regras de entrada
- Regras de funcionamento
- Regras de saída
- Trocas de informações (sip, sib, rps, tiss, tuss)
- Intervenções da ANS
- Direção técnica
- Direção fiscal
- Liquidação extrajudicial
- Alienação da carteira

O QUE VAMOS ESTUDAR

01
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

02
PRODUTO
Planos privados de assistência à saúde ou odontológicos

03
OPERADORAS DE SAÚDE

04
REGULAÇÃO ANS

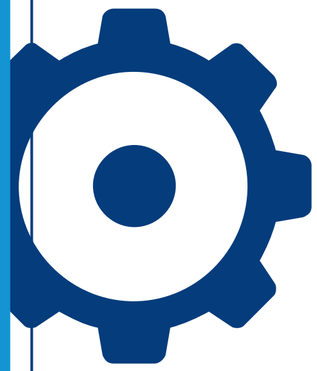
05
INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Neste bloco, estudaremos:

AGÊNCIA REGULADORA ANS

MECANISMOS DE REGULAÇÃO



REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

ANS

Criada a partir da promulgação da Lei no. 9961, de 2000, é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil.

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

MISSÃO

Promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Agências reguladoras

DÉCADA DE 1990

Privatizações – Estado de produtor a regulador e interventor sobre as ineficiências ou falhas do mercado:

Assimetria de informações
Um agente do mercado tem mais informações relevantes e essenciais que os demais

Seleção adversa
Na realização de um negócio, uma das partes tem mais informação do que a outra (assimetria de informações) e, por causa dessa condição, a parte com menos informação é levada a tomar decisões de forma errada

Risco moral
Situação em que uma pessoa ou empresa terá tendência a correr riscos ou alterar o seu comportamento, porque os custos ou consequências negativas dessa decisão não serão sentidos por aquele que corre o risco. O custo ou a consequência financeira será para outrem

Demanda induzida pela oferta
Dependendo dos mecanismos de incentivo a oferta pode ocorrer em ambiente de superutilização ou uso desnecessário

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Motivadores para sua criação*

1. Assegurar aos consumidores de planos privados de assistência à saúde cobertura assistencial integral e regular as condições de acesso;

2. Definir e controlar as condições de ingresso, operação e saída das empresas e entidades que operam no setor;

3. Definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e financeiras que assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde contratados pelos consumidores;

4. Dar transparência e garantir a integração do setor de saúde suplementar ao SUS e o ressarcimento dos gastos gerados por usuários de planos privados de assistência à saúde no sistema público;

5. Estabelecer mecanismos de controle da abusividade de preços;

6. Definir o sistema de regulamentação, normatização e fiscalização do setor de saúde suplementar"

*Segundo Rebello Filho em SAÚDE SUPLEMENTAR: 20 ANOS DE TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS EM UM SETOR DE EVOLUÇÃO CONTÍNUA

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Planejamento Estratégico ANS 2021-2024, elaborado em 2020 de acordo com a Lei nº 13.848/2019, IN nº 24/2020 e Decreto nº10.382/2020

Foi revisto, alterado para 9 indicadores mas o quadro não sofreu alterações

Fonte: ANS

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Agenda regulatória ANS - 2023 - 2025

TEMAS REGULATÓRIOS

Temas para os quais serão realizadas Análises de Impacto Regulatório (AIR)

Objetivo: Orientar e subsidiar a tomada de decisão.

Exemplos:
- Melhoria do Relacionamento entre operadoras e beneficiários
- Mecanismos de Regulação Financeira
- Integração da Saúde Suplementar e o SUS
- Transparência e qualidade de dados e informações do setor

AGENDA DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO REGULATÓRIO (ARR)

Objetivo: Verificar os efeitos da edição dos atos normativos, considerando o alcance dos objetivos pretendidos e demais impactos observados.

Exemplos:
- Parâmetros da Metodologia de Reajuste Individual
- Análise sobre os conceitos de grupo econômico e rede própria na saúde suplementar
- Autogestões

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PRELIMINARES

Assuntos que serão estudados no período –

Objetivo: Aprofundar a temática e dar transparência dos resultados.

Exemplos:
- Seguro Garantidor
- Avaliação Econômico-Financeira dos Produtos

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

ANS como indutora de boas práticas para evolução do setor

- QUALISS
- Projeto Modelos de Remuneração Baseada em Valor
- Projeto Oncorede
- Parto Adequado
- IDSS
- Projeto Idoso Bem Cuidado
- Programas de Atenção à Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
- Projeto de Enfrentamento da Obesidade e Sobrepeso
- Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde
- Programa de Acreditação de Operadoras

Regras contratuais Operadoras-Prestadores – Fator de qualidade (apenas para aumentar a remuneração dos prestadores)

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Mecanismos de regulação

Meios ou recursos técnicos, administrativos ou financeiros utilizados pelas operadoras para gerenciamento da prestação de ações e serviços de saúde.

- Adotados pelas operadoras para controlar ou regular a demanda ou a utilização pelos beneficiários dos serviços cobertos nos planos de saúde.

- Os mecanismos de regulação adotados e todas as condições de cada modalidade devem estar previstos em contrato e informados clara e previamente ao beneficiário no material publicitário, no contrato e no “livro” da rede de serviços.

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Tipos de mecanismos de regulação

FINAN CEIROS

Franquia e Coparticipação

Autorização Prévia

Junta Médica e Odontológica

Direcionamento

Porta de Entrada

NÃO FINAN CEIROS

REGULAÇÃO - ANS E MECANISMOS DE REGULAÇÃO

Questões para Discussão e/ou entendimento do papel do seu negócio no mercado de Saúde Suplementar

1. Você identifica exemplos de falhas de mercado existentes ainda hoje no mercado de saúde suplementar? Cite exemplos.

2. Qual o impacto destas falhas no mercado de saúde suplementar? Quais os principais atores impactados?

3. Como você e/ou sua instituição e/ou negócio poderiam atuar para minimizar estes impactos?

4. Quais os principais impactados com o mecanismo da Junta Médica? Cite quais são estes impactos (positivos, negativos e a quais atores está associado).

5. Quais os principais impactos da Autorização Prévia? Cite quais são estes impactos (positivos, negativos e a quais atores está associado).

6. Quantos colaboradores existem na sua organização para a operacionalizar o processo de autorizações junto às operadoras de saúde?

7. Sua instituição participa de algum dos projetos de incentivo da ANS junto às operadoras?

8. Como sua instituição está no QUALISS?

O QUE VAMOS ESTUDAR

01
MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

02
PRODUTO
Planos privados de assistência à saúde ou odontológicos

03
OPERADORAS DE SAÚDE

04
REGULAÇÃO ANS

05
INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Operadoras são responsáveis pelo financiamento da assistência aos seus beneficiários junto aos prestadores de serviços

Financiamento da assistência prestada pelos médicos, terapeutas, hospitais, laboratórios de análises clínicas ou de imagem, entre outros

A operadora é, indiretamente, responsável pela assistência prestada aos seus beneficiários, pois os prestadores fazem parte da rede mantida e “indicada” por ela

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RELACIONAL

FINANCEIRA

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

Cumprimento de todas as normas que regulamentam as regras definidas pela ANS. Ex. trocas de informações no padrão TISS, coberturas do plano.

Importância: proporcionaram que hoje tenhamos dados e informações do setor

Oportunidade para a indústria de tecnologia, fornecedores e consultorias - operadoras e prestadores que não possuem equipes internas para adequações

Afetam forte e diretamente os prestadores que são obrigados a adequar seus processos e sistemas para a manutenção do vínculo com as operadoras

Esta interface envolve a padronização das informações a serem trocadas entre operadora e prestadores / ANS, regras de cobertura assistencial, cumprimento de prazos e adequações contratuais e de pagamentos.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RN 503/2022 – Contratos escritos devem conter:

Descrição dos serviços contratados com seus **valores e critérios**, forma e periodicidade de **reajustes** e dos prazos e procedimentos para **faturamento**, identificação dos procedimentos que **necessitem de autorização** da operadora, critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão, **penalidades** em caso de não cumprimento pelas partes.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RN 503/2022 – Contratos - Vedado:

I -qualquer tipo de exigência referente à apresentação de **comprovantes de pagamento da contraprestação** pecuniária quando da elegibilidade do beneficiário junto ao Prestador;

II - qualquer tipo de exigência que infrinja o Código de Ética das profissões ou ocupações regulamentadas na área da saúde;

III - exigir exclusividade na relação contratual;

IV - restringir, por qualquer meio, a liberdade do exercício de atividade profissional do Prestador;

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RN 503/2022 – Contratos - Vedado:

V - estabelecer regras que impeçam o acesso do Prestador às rotinas de auditoria técnica ou administrativa, bem como o acesso às justificativas das glosas;

VI - estabelecer quaisquer regras que impeçam o Prestador de contestar as glosas, respeitado o disposto nesta norma;

VII - estabelecer formas de reajuste condicionadas à sinistralidade da operadora; e

VIII - estabelecer formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do serviço contratado.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RN 502/2022 – Padrão TISS – Padrão Obrigatório de Troca de Informações na Saúde Suplementar

Objetivo é **padronizar** as ações administrativas, subsidiar as ações de **avaliação e acompanhamento econômico, financeiro e assistencial** das operadoras de planos privados de assistência à saúde e **compor o Registro Eletrônico de Saúde**

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RN 502/2022 – Padrão TISS – Padrão Obrigatório de Troca de Informações na Saúde Suplementar

É atualizado periodicamente e abrange a troca de dados entre:

- **operadoras**
- **prestadores**
- **ANS**
- **Contratantes de planos de saúde** (coletivos ou individuais/familiares)

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RN 502/2022 – Padrão TISS – Padrão Obrigatório de Troca de Informações na Saúde Suplementar

Está organizado em cinco componentes:

Organizacional - estabelece o conjunto de regras operacionais.

Conteúdo e Estrutura - estabelece a **arquitetura dos dados** utilizados nas mensagens eletrônicas e no plano de contingência, para coleta e disponibilidade dos dados de atenção à saúde.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO
OPERACIONAL

RN 502/2022 – Padrão TISS – Padrão Obrigatório de Troca de Informações na Saúde Suplementar

Está organizado em cinco componentes:

Representações de Conceitos em Saúde - conjunto de termos para identificar os eventos e itens assistenciais na saúde suplementar (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar - TUSS

Segurança e Privacidade - requisitos de proteção para assegurar o direito individual ao sigilo, à privacidade e à confidencialidade dos dados de atenção à saúde.

Comunicação - meios e os métodos de comunicação das mensagens eletrônicas

Adota a linguagem de marcação de dados XML - Extensible Markup Language.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

TUSS - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar - trabalho conjunto da ANS, AMB e o COPISS, baseada na CBHPM.

No setor de saúde suplementar existiam **inúmeras tabelas e falta** de padronização – Adoção de uma terminologia clínica comum

Se utilizam três tabelas

- **TUSS** – função exclusiva de padronização de nomenclaturas e codificações, usada para a troca de informações.
- **Rol de procedimentos**, para determinar quais as coberturas "mínimas obrigatórias"
- **CBHPM** que vincula com a valoração dos procedimentos.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

RELACIONAL

Menor impacto operacional mas de maior importância conceitual

Questões fundamentais: confiança, transparência, compartilhamento e redução da assimetria de informações

É a base para a Interface financeira

Necessidade de grande evolução

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Interfaces entre as Operadoras e os Prestadores

FINANCEIRA

Em evolução, de modelo de remuneração por serviço prestado - quanto mais se utiliza, mais se paga (fee for service) para modelos que valorizem a qualidade e o resultado da assistência prestada, a satisfação do beneficiário e a eficiência operacional

Compartilhamento de riscos entre operadora e prestador de serviços também têm sido discutidos, mas o risco que tudo isso pode gerar ao paciente, pode ser compartilhado?

Há inúmeros modelos sendo empregados, dos mais básicos aos mais evoluídos:

- Pacotes
- Diárias globais e taxas globais
- Pagamentos com base no DRG
- Capitation
- Bundled payment
- Remuneração baseada em valor

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Modelos de Remuneração

Fee for Service

Pagamento do serviço é feito **por item de serviço prestado**.

O contrato entre operadora e prestador contém todos os itens que podem ser cobrados.

A cada item utilizado cobra-se a **quantidade utilizada x valor unitário**

Desvantagem - imprevisibilidade de custos dos serviços, uma vez que variam em função da quantidade utilizada e dos tipos de serviços prestados. Variação de preços de materiais e medicamentos que adicionam um outro componente de imprevisibilidade. **Não há incentivo a racionalização de uso** de serviços já que todos são pagos.

Para o prestador - vantagem é que ele **não assume riscos financeiros** na prestação do serviço pois recebe por todos os serviços prestados. Nesse modelo **não há incentivo para a avaliação de custo/efetividade** dos procedimentos realizados assim como **materiais e medicamentos utilizados**.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Modelos de Remuneração

Pacotes

Os serviços **são agrupados** em procedimentos e **pagos de forma única** desconsiderando-se os itens utilizados

O **modelo padrão** de pacote inclui procedimentos cirúrgicos de **baixa complexidade e variabilidade** e pressupõe regras específicas de aplicação. Isso ocorre porque nesse modelo o **prestador de serviços começa a assumir riscos financeiros** já que valores que excedam o limite dos pacotes não serão pagos.

Vantagens: Maior **previsibilidade** dos custos das operadoras, **reduzem os gastos operacionais com controles** (ex. auditoria, pagamento de contas médicas) e aumenta a necessidade de **racionalização dos recursos**.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Modelos de Remuneração

Diárias Globais e Taxas Globais

Evolução do pacote na qual as **diárias (UTI, apartamento ou enfermaria**) são agrupadas e pagas **por dia de internação.** O mesmo ocorre com as **taxas de sala** cirúrgicas que são pagas no formato de **pacote por porte cirúrgico.**

Previsibilidade por parte das operadoras – pacotes além dos cirúrgicos básicos.

Itens como **exames, materiais, medicamentos e serviços são acrescidos à diária e pagos como diária global**. Há um aumento da previsibilidade da conta já que abrange uma grande gama de internações clínicas facilitando a gestão operacional da conta médico hospitalar.

Gestão do tempo de internação é muito importante.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Modelos de Remuneração

Pagamento com base no DRG

Diagnosis Related Groups (DRG)

DRG - Objetivo de fazer uma **classificação de gravidade**. Camada para aprimorar os custos e ajudar a estabelecer preços mais acurados pelos prestadores. Cria grupos homogêneos para facilitar a aplicação do modelo de remuneração específico.

Considera indicadores (diagnóstico principal, diagnósticos secundários, procedimentos cirúrgicos realizados, características do paciente como peso, idade, comorbidades e complicações) para a classificação dos pacientes e **aqueles com características semelhantes agrupados**. Grupos homogêneos são criados - **facilita a comparação de desfechos, custos e o estabelecimento da remuneração necessária**. O DRG **NÃO é um sistema de remuneração** e sim um modelo de classificação de eventos que pode funcionar como base de precificação para diferentes modelos, desde pacotes simples ajustados por risco até modelos baseados em valor.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Modelos de Remuneração

Capitation

Pagamento da atenção a saúde ocorre de forma **percapita** (por pessoa) para uma população delimitada e fechada

Risco maior para o prestador de serviço - o valor é fixo ao longo do tempo e independe da evolução de gravidade da população atendida.

Essa avaliação de gravidade é estabelecida a priori quando se determina o valor do pagamento per capita.

Vantagem para a operadora - **controle e previsibilidade** além de importantes **ganhos operacionais**.

Modelo que **incentiva o subtratamento e seleção de risco**. Problema - desfechos no longo prazo, já que o **subtratamento pode ter efeitos deletérios na saúde** da população coberta por esse modelo com **reflexo nos custos futuros.**

É aplicado na negociação entre operadoras.

INTERFACE OPERADORAS E PRESTADORES DE SERVIÇO

Bundle Payment for Care Improvement

Modelos de Remuneração

Pagamento de todos os serviços realizados em um episódio de atenção à saúde (episode-based) - período definido em que há o tratamento de uma determinada condição de saúde – episódio de cuidado, não ficando restrito apenas ao cuidado intra-hospitalar ou de intervenções isoladas.

Vantagem para a operadora - **paga pela atenção à saúde e não pelos eventos realizados incentivando o prestador de serviço a ser mais eficiente no uso do recurso.**

Desvantagem - o beneficiário deve ser tratado numa linha de cuidado e gerenciado para não procurar diferentes prestadores de serviços, situação na qual haverá **pagamento em duplicidade**.

Prestador - **Risco financeiro - problemas inesperados** no cuidado de longo prazo podem não ser adequadamente remunerados. **Somente prestadores preparados tecnicamente, com recursos humanos competentes e experiencia comprovada no procedimento conseguem realizar seu custeio correto dentro de um episódio de atenção à saúde. Necessidade de maiores volumes que minimizem o risco financeiro.**

CONCEITO

DESPESA ASSISTENCIAL	Tudo o que é pago pelas despesas assistenciais/sinistros
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA	Mensalidade/prêmio cobrado pela operadora dos seus clientes individuais ou corporativos

= **SINISTRALIDADE**

É fundamental avaliar a SINISTRALIDADE para o entendimento do resultado financeiro de uma operadora de saúde

A sinistralidade pode ser elevada por uma desproporção entre as despesas e as contraprestações, ou seja, para a sinistralidade ser elevada é necessário que as mensalidades recebidas pelas operadoras sejam insuficientes frente às despesas assistenciais

Pode-se influenciar a sinistralidade atuando no numerador (despesas assistenciais / sinistro) ou no denominador (contraprestações / mensalidades / prémios)

E COMO ATUAR SOBRE AS CAUSAS DA SINISTRALIDADE ELEVADA?

Sinistralidade elevada

Custo assistencial elevado

- **Modelo** curativo x preventivo
  Cuidado fragmentado e descoordenado, práticas administrativas obsoletas e modelo de remuneração
- Judicialização
- "Politização"
- Incorporação tecnológica
- Baixa qualidade da assistência / formação dos profissionais
- Transição epidemiológica / envelhecimento da população

Mensalidade baixa

- Venda (preço de entrada)
- Competição / concorrência
- Down grade de planos

DESPESAS ASSISTENCIAIS

As despesas assistenciais (também chamadas de sinistros) são fundamentais para a continuidade das operadoras de saúde, mas não com as taxas de sinistralidade nos níveis apresentados nos últimos anos

Focaremos agora na redução das despesas assistenciais (Controle de Sinistros)

Cuidado na busca da redução das despesas assistenciais – **É necessário: racionalização no uso dos recursos e tratamentos empregados, mas com foco na qualidade da assistência e não em detrimento dela.** Deve-se minimizar os custos assistenciais focando na eliminação dos desperdícios existentes em toda a cadeia

Todos devem ser envolvidos, desde as operadoras e prestadores de serviços, a indústria de insumos relacionados à saúde, as empresas contratantes, fornecedores de insumos e os beneficiários

As operadoras de planos de saúde estabelecem algumas estratégias para a gestão das despesas assistenciais, divididas em **gerenciamento da utilização e gerenciamento da rede de prestadores**

DESPESAS ASSISTENCIAIS

Estratégias para a gestão das despesas assistenciais

GERENCIAMENTO DA UTILIZAÇÃO

- Autorização Prévia
- Junta Médica ou Odontológica
- Franquia ou Coparticipação
- Direcionamento
- Porta de Entrada

📫 Ações de Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças
📫 Gerenciamento de Crônicos
📫 Gerenciamento de Casos
📫 Atenção Domiciliar

GERENCIAMENTO DA REDE

- Forma de contratação
- Remuneração/Compartilhamento Risco
- Acompanhamento dos custos, frequências, tempos de permanência, desfechos/resultados assistenciais
- Direcionamento de casos
- Auditorias Médicas e de Enfermagem
- Redimensionamento da Rede

VERTICALIZAÇÃO

MUDANÇAS ESTRUTURAIS

Regulação consumerista

Abertura do mercado de saúde para investimento estrangeiro

Aporte de fundos de investimentos nacionais

MOVIMENTOS

Prestadores criando planos de saúde

Operadoras oferecendo serviços próprios aos beneficiários

Movimentos de fusão e aquisição culminando na integração vertical

VERTICALIZAÇÃO

Ocorre ou é justificada como ferramenta para corrigir as falhas de mercado tão preponderantes na saúde, como a assimetria de informação, o risco moral e a demanda induzida pela oferta

Tenta endereçar o problema relacionado ao modelo de pagamento preponderante (Fee for Service)

Tópicos anteriores levam a um **cenário de sobreutilização**

VERTICALIZAÇÃO

PRÓS

Alinhamento de incentivos levando à não sobreutilização

Maior sustentabilidade econômica com controle da sinistralidade

Planos mais acessíveis e ampliação do acesso

Cuidado mais alinhado - melhor qualidade com racionalidade

CONTRAS

Excesso de competição levando ao esmagamento da margem de concorrentes e explusão do mercado

Redução da concorrência - não redução de preços - redução do acesso

Cenário de subutilização pois incentivos inadequados com redução de tratamentos necessários (principalmente os mais caros)

Cuidado inadequado, piora na qualidade

MUITO OBRIGADA

REGINA MELLO
reginaarrudamello@gmail.com